

醫師評論者的歷時軌跡如何塑造信任與醫師選擇？

後設資料

想法編號: seed-domain-6=>3=>2=>2

新穎度: 26.3%

最大相似度: 73.7% (近似於: “How reviewers’ profiles affect user’s judgment of physicians”)

群集: 0

競賽得分: 3 勝

方法論契合度: 1/5

問題陳述

現有關於線上醫師評論的研究，多半把評論者視為一個「靜態來源」：研究者關注其頭像、匿名程度、是否揭露興趣、單則評論的正負向、長度、可讀性、或特定主題內容，進而推論使用者是否信任該評論、是否採納其意見。然而，真實使用情境中，讀者往往不是只看一則評論，而是會在平台上反覆接觸同一評論者的多則貼文、跨時間的發言紀錄、主題偏好與情緒走向。這使得評論者不再只是單次訊息的發送者，而是被當作一個具有「可追蹤經驗履歷」的資訊主體。問題在於，既有模型缺乏對這種歷時性來源特徵的解釋能力，導致我們無法回答：一個長期穩定評論婦產科的使用者，是否比偶爾才發文、但每次都都很激烈的使用者更可信？一位在某次就醫挫折後連續發表負評的人，是否會比偶發一次情緒性負評的人更被視為「有真實經驗」？評論者的主題專精、經驗一致性、情緒波動與評價策略，是否會形成可辨識的類型，並在正評與負評情境中產生不同的信任效果？

這個問題之所以重要，是因為醫師選擇具有高度風險、資訊不對稱與情緒涉入。若使用者被不穩定、但表面上很有戲劇性的評論所引導，可能產生錯誤就醫決策；若平台只鼓勵匿名單點評論，也可能放大噪音、削弱真正有長期經驗的病患聲音。從圖書資訊學與資訊行為角度看，這涉及線上資訊來源可信度、社會訊息處理、知識組織與證據加總；從醫療資訊研究角度看，則涉及病患如何以有限線索判斷醫師服務品質。更進一步，本研究也可回應平台治理與健康資訊公平性的議題：誰的評論更容易被相信、哪些歷時性型態會被系統性低估，這些都會影響醫療決策權的分配。

現有方法

既有方法大致可分為三類。第一類是單次來源線索研究，常以評論者頭像、ID、匿名性、個人簡介、是否揭露興趣、是否標示非贊助等作為外在線索，搭配單一評論效價來觀察信任與採納行為。其限制在於，這類方法把來源可信度當作靜態屬性，忽略來源在時間上的一致性與演化。第二類是評論內容分析或情緒分析，常研究評論長度、主題、情緒詞、醫療服務面向、正負評比例、或有用性投票。其限制是偏向「文本特徵」而非「評論者軌跡」，因此無法區分一位長期專注某科別、語氣穩定的評論者，與一位四處發文、情緒起伏大的評論者。第三類是時間序列或長期評論研究，主要用於產品評論、飯店評論或電商情境，分析評論數量、評分趨勢、事件衝擊、評分分布與口碑擴散；但這些研究多以產品或商家為單位，很少把「評論者本身」作為歷時分析對象，更少把分析結果連結到讀者的認知信任與醫師選擇。

可作為比較基準的模型包括：以評論者統計特徵為主的邏輯斯迴歸、以文本嵌入結合注意力機制的分類模型、以評論內容與時序特徵做分群的傳統聚類、以及以實驗方式操作匿名性與評論效價的組內設計。但這些基線的共同不足是：無法捕捉「同一評論者在多次評論中的穩定模式」，也無法辨識「事件驅動型」或「情緒波動型」等結構化歷程。換言之，現有研究能回答「這則評論像不像可信來源」，卻不能回答「這個評論者的長期經驗軌跡像不像可信來源」。

研究動機

本研究的核心動機，是把「信任」從單點訊息判斷，轉變為對來源生命史的推理。使用者在閱讀醫師評論時，實際上會做一種近似法醫式的判斷：這個人是不是長期真的在這個領域有經驗？他是在重複、累

積、穩定地描述相似問題，還是只在某次極端事件後突然大量發言？他的情緒表達是否與醫療經驗的嚴重程度相符？如果一位評論者在多年內持續針對同一類醫療服務給出一致負評，讀者可能會把這種穩定性解讀成「高資訊價值」與「真實經驗痕跡」；相反地，一位高強度但只有一次的負評，可能因為過度戲劇化而被視為個案抱怨。這種反直覺的判斷，其實是資訊行為研究中非常值得解釋的現象。

既有方法之所以不足，是因為它們多半假設信任來自「單次品質」或「單次外觀」，但在平台化醫療資訊環境中，使用者越來越像在做來源聲譽推理：他們會把評論者視為可追蹤的「經驗檔案」。因此，本研究提出一個更激進但可行的想法：把評論者軌跡建模為一種「經驗指紋」或「信任足跡」。若某人長期在特定主題上維持高一致性、低跨域漂移、適度情緒表達與清楚的評價策略，他就可能被讀者視為穩定專精型；若某人平時沉默，僅在特定醫療事件後集中發言，則可能是事件驅動型；若某人語氣與評價起伏大、主題跳躍頻繁，則可能是情緒波動型。這些型態不只可以描述來源，也可以預測來源在正負評情境下的說服力差異。

本研究之所以可能比既有基線更有效，是因為它同時利用了三種資訊：時間、主題與情緒。時間提供穩定性證據，主題提供專精性證據，情緒提供真實性與風險感知線索。這三者的交互作用，能比單一外在線索更接近讀者在真實平台上的信任形成機制，也更符合健康資訊決策的高風險特性。

提出方法

本研究提出一個名為「評論者經驗軌跡信任框架」的整合式方法，將醫師評論者的歷時行為轉化為可量化、可解釋、可實驗驗證的信任線索。整體流程分為四層：資料層、軌跡層、類型層與驗證層。

第一層是資料層：從台灣醫師評價平台、健康論壇與可公開取得的評論網站蒐集評論者的長期發文紀錄，建立評論者—評論—醫師—時間的四元資料結構。每筆資料至少包含評論者匿名 ID、發文時間、醫師科別、主題標記、評分、文字內容、是否回訪、是否提及具體就醫事件、情緒強度與建議意圖。若平台允許，進一步蒐集評論者在不同醫師上的跨主題紀錄，以建構「經驗域」而非只看單一醫師的歷程。為了避免只看活躍用戶，需設定最低時間跨度與最低評論數門檻，讓軌跡分析有足夠穩定性。

第二層是軌跡層：把每位評論者的評論歷史轉換成多維時間序列。這裡不只記錄正負評比例，還記錄四個核心指標。其一是經驗一致性，衡量同一評論者在時間上是否持續發表相似醫療主題、相似科別或相似服務面向的評論，可用主題分布的熵、相鄰評論主題距離、以及跨期主題漂移量來表示。其二是主題專精度，衡量評論者是否長期集中在少數主題或科別，可用集中度指標、Herfindahl 指數或主題專注度來估計。其三是情緒變化，將評論中的情緒強度、情緒極性與情緒轉折點建模成序列，可辨識穩定低情緒、逐步升高、突發爆發或來回震盪等模式。其四是評價策略，指評論者是否偏好描述性證據、敘事性故事、比較式判斷、警告式措辭或建議式措辭。這部分可透過內容分析與大型語言模型輔助標註，形成可訓練的策略分類器。

第三層是類型層：以潛在類別分析、序列聚類或隱馬可夫模型，將評論者分成若干「信任軌跡類型」。初步假設至少可形成三類：穩定專精型、事件驅動型、情緒波動型。穩定專精型的特徵是長期聚焦少數醫療主題，敘事節奏穩定，評價策略一致，情緒幅度中等但不戲劇化。事件驅動型的特徵是平時較少發文，但在某些具體醫療事件後密集輸出，評論內容高度情境化，情緒強度高且與事件相呼應。情緒波動型則呈現高變異的評價與情緒跳動，主題跨域較大，可能在不同醫師、不同科別間切換，信號看似豐富但不穩定。若資料量足夠，也可發展第四類，例如「審慎觀察型」：主題多樣但語氣平穩、細節豐富、評價傾向保留。每一類都可由時間序列特徵、主題分布與情緒曲線共同定義，而不是只靠單次文本。

第四層是驗證層：先以離線資料建立評論者類型，接著設計受試者實驗測試其因果效果。實驗中，不是只呈現一則評論，而是呈現同一評論者的「迷你時間軸」，例如 4 至 6 則跨時間評論摘要，讓受試者感知來源的長期軌跡。實驗操縱的重點包括：類型（穩定專精型 vs 事件驅動型 vs 情緒波動型）、評論效價（正評 vs 負評）、以及軌跡一致性（連續一致負評 vs 單次高強度負評 vs 先正後負的轉折型）。受試者先評估評論者的認知信任、情感信任、專業感、真實性感與可依賴性，再做醫師選擇或採納意向判斷。若要更具創意，可加入一個「評論者履歷卡」介面，讓受試者像查看 LinkedIn 一樣查看評論者的醫療評論軌跡，但不透露真實身份，僅展示時間分布、主題標籤與情緒曲線，測試這種履歷化呈現是否會提升信任判斷的準確性。

本研究最關鍵的創新在於，它不是把評論者當作一個固定來源，而是把其過去的發言當成可累積的

證據鏈。理論上可用社會訊息處理理論解釋：讀者會從軌跡一致性中推論來源穩定性；也可用線索利用理論解釋：當單次內容品質不足時，使用者會倚賴歷時線索來補足不確定性。若結果支持假說，將能提出一個更動態的醫師評論信任模型：信任不只來自評論說了什麼，也來自這個人長期怎麼說、何時說、對什麼說，以及情緒如何隨經驗變化。這會把 target paper 的單點經驗線索推進為一個可計算的歷時信任機制。

實驗計畫

第一步：資料蒐集與樣本建置。先選定 2 至 3 個台灣可公開存取的醫師評價平台，使用爬蟲蒐集至少 3 年以上的歷史評論。資料單位為評論者而非評論本身，目標是保留每位評論者至少 8 則以上評論，並涵蓋不同時間點與不同醫師。同步建立醫師科別、評論日期、評分、評論文本、字數與回覆互動資料。接著進行去識別化與資料清理，排除廣告、洗版、重複貼文與明顯非病患經驗內容。

第二步：標註與特徵工程。抽樣約 1,000 則評論進行人工標註，標記主題面向、情緒極性、情緒強度、敘事型態、證據密度與評價策略；兩位以上編碼者計算一致性。再利用標註資料訓練輔助分類器，擴展至全體評論。時間序列特徵包括評論間隔、主題轉移率、情緒斜率、極值次數、主題熵、科別集中度與策略穩定度。

第三步：評論者類型建模。使用潛在類別分析、序列聚類或隱馬可夫模型，將評論者分群，並比較不同模型在貝氏資訊量準則、輪廓係數與可解釋性上的表現。若資料足夠，可將類別數設定為 3 至 5 類，優先選擇可解釋且穩定的分類結果。預期至少會辨識出穩定專精型、事件驅動型、情緒波動型三類。

第四步：離線效度檢驗。比較不同類型評論者在可用性、可信度代理指標上的差異，例如平均按讚數、留言互動、收藏率或平台上的有用性投票。若平台沒有投票資料，可比較文本被引用、被轉貼或被平台推薦的機率，確認類型具有現實區辨力。

第五步：情境式受試者實驗。招募 120 至 180 位最近一年內曾使用醫師評論網站的受試者。採組內或混合設計，隨機呈現同一醫師在不同評論者類型下的迷你時間軸介面。每個情境包含評論者的 4 至 6 則歷史摘要，讓受試者感知其長期軌跡。實驗條件至少包含：穩定專精型 vs 事件驅動型 vs 情緒波動型，以及正評與負評兩種效價。可進一步操縱「連續一致負評」與「單次高強度負評」兩種敘事形式，以測試哪一種更具說服力。測量變項包含認知信任、情感信任、評論可信度、專業感、真實性感、採納意向與最終醫師選擇。

第六步：分析方法與統計檢驗。主要分析可採混合效果模型或重複量數 ANOVA，檢驗評論者類型、效價與軌跡一致性的主效應與交互作用；若要更細緻，可用中介分析檢驗「類型 → 認知信任 → 醫師選擇」的路徑，並比較正評與負評是否存在不同機制。預期關鍵結果包括：1) 穩定專精型在雙向效價下都較高認知信任；2) 事件驅動型在負評情境中可能因「真實性」而獲較高可信度；3) 情緒波動型雖引人注意，但對最終選擇的正向影響最低；4) 連續一致負評若具有足夠主題與時間一致性，可能比單次高強度負評更能促發信任與採納。

第七步：成功判準。若本研究能同時達成三項結果，即可視為成功：一是能從評論者歷史中穩定萃取出具解釋力的類型；二是這些類型能顯著預測讀者的認知信任與醫師選擇；三是歷時一致性比單次情緒強度更能解釋可信度差異。若進一步證明「履歷化呈現」優於只看單則評論的呈現方式，則代表本研究不只是描述現象，而是提供可直接應用於醫療評論平台設計的實證依據。

可信新穎度 — 最接近的真實論文

- How reviewers' profiles affect user's judgment of physicians (73.7% · airtiti.AL, 2023) — 增量: 本提案不是只操弄評論者的單次身份或經驗線索，而是把評論者當作可被追蹤的歷時主體，分析其跨時間的評論軌跡、主題專精、情緒波動與評價策略如何累積成信任。該論文主要是用情境實驗檢驗匿名評論網站中「身份線索 / 經驗線索」對使用者判斷醫師的影響，焦點在單一評論者當下呈現的社會線索，而不是長期發文履歷與序列型態。
- How Reviewer Profiles and Review Volume in Product Ratings Affect Viewers' Purchasing Intention and Trust (61.8% · airtiti.AL, 2018) — 增量: (模型未提供差異說明；以相似度為準)

- What Makes Helpful Online Reviews to the Formation of Trustworthiness? An Experimental Study on the Effectiveness of Review Arrangement across Products (57.8% · airiti.AL, 2011)
— 增量: (模型未提供差異說明；以相似度為準)

參考文獻

1. How reviewers' profiles affect user's judgment of physicians
2. Longitudinal Analysis of Online Consumer Reviews
3. Are negative reviews more credible and useful? The moderating effects of negative emotions and product types
4. This is NOT a Sponsored Review: The Effect of Non-Sponsorship Disclosure On Source Credibility of Online Product Opinions
5. The Impact of Online Consumer Review (OCR) on Perceived Credibility: the Moderating Effect of Codeswitching.
6. The Impact of Online Review Related Credibility on Behavioral Intentions on Online Platform
7. Investigating the Structural and Textual Characteristics of Internet Physicians Review
8. The Study of Relationship Between Breast Cancer Patients' Trust and Evaluation toward Physician
9. The Determinants and Outcome of Trust Between Patient and Doctor - In case of Hemodialysis Centers
10. The Relationship among Trust, Satisfaction and Loyalty in Professional Medical Services: The Case of Taiwan
11. The Influences of Characteristics of Medical Institutions and Physicians on Physicians' Choice of Surgical Methods of Intracranial Aneurysms
12. Are Negative Online Reviews Better? A Case Study of Hotel
13. A Study of Identifying Factors of Influencing Trust in O2O Models: An Example of OpenTable
14. External Cue Consistency in Online Auction : Effect of Starting Price and Sellers' Rating Under Different Information Asymmetry Levels
15. The Impact of Information Quality and Perceived Risk on the Adoption of Google Reviews
16. A Sentiment-Based Model for Credible Online Reviews
17. Information Asymmetry, Trust, and Purchase Intention in Sharing Economy Platforms - Reputation and the Feedback Mechanism as Moderators
18. Research on Consumer Praise Review on Online Shopping Platform
19. 訊息來源與產品種類相關性、訊息來源可信度、消費者涉入程度對產品態度之影響
20. Effect of External Source Credibility of Online Games Word-of-Mouth on Consumer' s Selection Intention: Internal Factors of Receiver

21. Development of a Scale for Measuring the Source Credibility of on-Line Word-of-Mouth
22. A Bayesian Statistical Model Based Outpatient Department Decision Support
23. The Study of Impact Factors and Prediction Models on Patients' Health Care Behavior
24. A Survey of New Hospital Patients on Their Selection of Medical Information Media and Care Providers
25. Fake Review Identification – a comparison between human labeling and the use of the pre-trained large language model
26. A Semi-Supervised Deep Learning Model for Fake Review Detection
27. The Effects of Negative Online Reviews and Seller's Feedback on Consumer Purchase Intention
28. Whose online reviews to trust? Understanding reviewer trustworthiness and its impact on business
29. Impact of Anonymity on Consumers' Online Reviews
30. Toward a more robust theory and measure of social presence: Review and suggested criteria
31. Social Presence on LinkedIn: Perceived Credibility and Interpersonal Attractiveness Based on User Profile Picture
32. Online first impressions: Person perception in social media profiles
33. Profile Photos' Impact in Online Reviews: The Effect of Cultural Differences
34. Risk assessment in e-commerce: How sellers' photos, reputation scores, and the stake of a transaction influence buyers' purchase behavior and information processing
35. Examining the relationship between reviews and sales: the role of reviewer identity disclosure in electronic markers
36. How fakes make it through: the role of review features versus consumer characteristics
37. The effects of review valence in organic versus sponsored blog sites on perceived credibility, brand attitude, and behavioural intentions
38. An examination of negative e-WOM adoption: Brand commitment as a moderator
39. Eight Questions About Physician-Rating Websites: A Systematic Review
40. An Analysis of Online Evaluations on a Physician Rating Website: Evidence From a German Public Reporting Instrument
41. A Changing Landscape of Physician Quality Reporting: Analysis of Patients' Online Ratings of Their Physicians Over a 5-Year Period
42. What Do Patients of Different Medical Illness Say About Their Doctors Online? An Analysis of Online Physician Reviews

匿名醫師評論平台中，評論者資料豐富度與評論量能否替代身份揭露以建立信任？

後設資料

想法編號: seed-theory-3=>1=>2=>2

新穎度: 36.1%

最大相似度: 63.9% (近似於: “How reviewers’ profiles affect user’s judgment of physicians”)

群集: 1

競賽得分: 3 勝

方法論契合度: 4/5

問題陳述

匿名醫師評論平台在醫療資訊取得上扮演越來越重要的角色，但其核心矛盾也非常明確：平台為保護病人隱私而採匿名設計，卻正是這種匿名性削弱了使用者對評論者的信任，進而降低評論的採納與醫師選擇意願。使用者在面對一則醫師評論時，往往無法判斷評論者是否真的有看診經驗、是否具備足夠專業背景、是否只是情緒宣洩，或是否是刻意操弄的意見。這種不確定性在高風險、低可逆性的醫療決策情境中特別嚴重，因為錯誤判斷可能影響就醫成本、治療延誤與後續健康結果。

本研究欲處理的問題是：在不破壞匿名與隱私的前提下，平台能否透過設計「替代信號」來重建信任？這些替代信號不僅包括一般性的社會線索，例如頭像、簡短簡介、過往評論數，也包括更貼近醫療情境的健康經驗線索，例如「有慢性病經驗」「固定回診」「照顧家人就醫」等。研究的關鍵不只是測試信任是否上升，而是要釐清：哪些線索是有效的，哪些只是表面裝飾；哪些對正面評論有用，哪些對負面評論更有說服力；哪些對醫療評論新手有幫助，哪些對重度網路評論使用者反而只是雜訊。

本研究的重要性在於，它同時觸及資訊行為、社會訊息處理、醫療資訊信任與平台設計等核心議題。若能找出足以替代身份揭露的信號組合，平台就可以在不增加隱私風險的情況下，提高評論可用性與醫師選擇品質。若發現某些健康相關線索比一般社會線索更能建立信任，則可進一步推動匿名醫療評論平台朝向更精準、更情境化的介面設計，這對台灣與國際醫療資訊生態都具有高度實務與理論價值。

現有方法

既有研究大致分為三類。第一類是探討匿名性、頭像、ID、評論者經驗與評論效價如何影響信任與採納意圖的實驗研究。這類研究已指出，身份線索與經驗線索會透過社會臨場感、感知可信度或認知/情感信任影響使用者判斷，但多半只測試單一或少數線索，且常把「匿名」視為二元變項，無法反映實際平台中多層次的可見資訊。第二類是針對一般電商或旅遊評論的可信度研究，常以評論長度、星等、是否有圖片、評論數、平均分數等作為可信度或有用性的預測因子；然而這些結論未必能直接套用到醫療情境，因為醫療選擇涉及較高風險、較強專業不對稱與更敏感的隱私考量。第三類是平台端的聲譽系統、徽章制度、貢獻度排行榜與「有幫助」投票機制，這些可以提升社群治理，但主要建立在累積式聲譽，不一定能回答單一評論曝光瞬間的信任形成問題。

這些方法的限制也很明顯：1. 線索設計過於單薄，常把評論者資訊簡化為「有照片/無照片」或「有/無歷史評論」，缺少對資料豐富度層級化的操弄。2. 大多只看正面結果指標，如有用性、購買意圖，較少同時區分認知信任與情感信任，更少處理醫療情境中的醫師選擇意向。3. 多數研究未將使用者經驗差異納入設計，因此無法解釋為何同一線索對不同族群產生不同效果。4. 對評論內容本身的診斷細節關注不足，導致無法理解「線索」與「內容」如何交互作用；事實上，醫療評論若內容具體、具診斷/就

醫過程細節，可能比空泛情緒語句更能觸發專業性推斷。5. 缺乏對健康相關個人經驗線索的系統比較，平台往往只放社會型訊號，卻不知道與醫療相關的自我揭露是否更有效。

研究動機

既有方法之所以不足，是因為它們把信任視為單一結果，卻忽略了信任形成其實是一個「不確定性管理」過程。對匿名醫師評論而言，使用者最在意的不是評論者是誰，而是：他是否真的看過醫師？他是否有能力判斷？他的經驗和我有沒有關聯？他的評論是不是只是發洩？因此，若平台只提供最小化資訊，使用者會依賴粗糙捷思，例如星等、情緒詞或「看起來像真的」的表徵。

本研究的創新動機來自兩個觀點。第一，匿名平台不一定要走向「揭露身份」才能建立信任，而可以透過可驗證、低隱私風險的資料豐富度來取代身份揭露。也就是說，真正有效的可能不是姓名，而是某種足以支撐推論的「證據密度」：例如完整簡介、醫療相關經驗、過往評論的專門性、評論數量與時間分布。第二，使用者並非同質。醫療評論新手可能更依賴顯性的社會線索與健康相關自我揭露；而熟練的網路評論使用者可能更看重訊息結構、內容診斷細節與過往可信度模式，因此同一組信號在不同族群上的作用可能完全不同。

因此，本研究預期能比既有研究更好地解釋：為什麼某些匿名評論仍然被信任，為什麼負評有時反而更像真話，為什麼高評論量可能成為「社會證明」，也可能被視為「職業評論者」的警訊。若能建立一個「評論者資料豐富度 × 評論量 × 診斷細節 × 評價方向 × 使用者經驗」的整合模型，就能超越單一線索研究，形成對匿名醫療評論平台更具可操作性的設計原則。

提出方法

本研究提出一個名為「分層替代信號信任模型」的研究設計，核心假設是：在匿名醫師評論平台中，使用者並非直接依賴身份揭露，而是透過多種可見訊號拼湊出對評論者的可信度判斷。這些訊號可分成三層：第一層是基礎身份可見度，例如僅有頭像、頭像加簡短簡介、頭像加醫療/健康相關簡介與過往評論軌跡；第二層是累積性聲譽訊號，例如過往評論總數、在醫療領域的持續活躍度、最近一次評論時間；第三層是文本證據訊號，例如評論是否提供具體診斷細節、就醫流程描述、症狀與治療反應。

研究不把這些訊號單獨看待，而是把它們組合成不同強度的「替代信號包」，用來模擬平台設計可以呈現的不同層級。具體而言，建議採用一個 $2 \times 3 \times 2 \times 2$ 的混合實驗架構：評論效價（正評 vs 負評）× 評論者資料豐富度（低：僅頭像；中：頭像 + 一般簡介；高：頭像 + 健康/醫療相關簡介 + 過往評論歷史）× 評論量（少 vs 多）× 診斷細節（低 vs 高）。若要更貼近真實平台，也可將資料豐富度細分為一般社會線索與健康相關線索兩個維度，進一步檢驗「健康經驗」是否優於「社交型自我呈現」。

理論上，本研究把信任拆解為三個中介機制：一是認知信任，來自於使用者判斷評論者具備知識、經驗與判斷能力；二是情感信任，來自於使用者感知評論者真誠、善意、非操弄；三是診斷自我相關性，指評論內容與自己健康情境的可移植程度。高資料豐富度與高評論量預期會降低不確定性，提升認知信任；健康相關簡介預期會增加情感信任與經驗相似感；高診斷細節則會強化內容的可驗證性與情境貼合度，讓使用者更容易把評論當成「可用的證據」而非單純意見。

為了讓設計更「瘋但可行」，本研究建議額外加入一個「偽裝式平台介面」實驗：使用者看到的不是抽象刺激，而是仿真的醫師評論頁面，頁面中會以視覺方式呈現頭像、ID、評論數、評論歷史、健康經驗標籤與評論內容摘要。這樣可以測試真實平台設計的注意力分配與捷思判斷。研究可進一步加入「不確定性指標」操弄，例如在部分條件下顯示「此評論者曾回報慢性病經驗」或「此評論者過去 12 個月發表 18 則醫療相關評論」，藉此比較一般社交線索與健康特定線索的效能。

本研究的主要因變項包括：1. 認知信任：評論者是否被視為有能力、有知識、可信。2. 情感信任：評論者是否被視為真誠、善意、無惡意操弄。3. 感知專業性：評論者是否被認為了解醫療情境。4. 醫師選擇意圖：是否願意依據評論做出看診選擇。5. 有用性感知與不確定性降低：作為補充結果，檢驗訊號是否真的在「降低模糊性」。

本研究的分析方法可採混合效應模型或多層次模型，因為同一受試者會評估多組刺激。若進一步加入眼動或停留時間資料，還可檢驗使用者是否真的先看評論者資訊再讀內容，或反而先被評論內容牽引。

若條件允許，也可加入事後訪談，詢問受試者到底是靠什麼判定可信：是頭像、評論數、健康經驗，還是覺得內容太細所以像真的。這能把實驗結果轉化為更有解釋力的資訊行為理論。

實驗計畫

第一步，建立刺激材料。先收集並改寫真實醫師評論平台的頁面元素，製作一套仿真介面。評論者資料豐富度設計為三層：低層只有匿名頭像；中層加入簡短一般自介；高層加入健康/醫療相關自介、過往評論歷史與總評論數。評論量設計為少與多兩種版本，例如 2 則 vs 30 則歷史評論摘要。診斷細節設計為低與高兩種：低細節是模糊描述，如「醫師態度很好、看診很快」；高細節則包含症狀、檢查過程、用藥反應、候診體驗等具體資訊。評論效價採正評與負評各若干篇，且在字數、可讀性、語氣強度上盡量平衡。建議先進行前測，請獨立樣本評估所有刺激的可信度、情緒強度、具體性與醫療相關性，以確保操弄成功。

第二步，招募受試者並分群。樣本建議至少 160 到 240 人，以支持多因子重複量數分析。受試者需具備近期使用線上評論經驗，並在前測問卷中測量其「線上評論熟練度」「醫療評論使用頻率」「一般網路資訊搜尋習慣」等，據此區分為新手與熟手兩群。也可另外收集是否具有慢性病經驗、家屬照顧經驗或固定回診經驗，作為健康相關個人背景變項。

第三步，正式實驗。受試者在模擬平台中閱讀多組醫師評論情境。每個情境中顯示醫師基本資訊後，呈現一位匿名評論者及其評論內容。受試者需依序完成：對評論者的認知信任量表、情感信任量表、感知專業性、感知診斷細節、有用性感知、不確定性降低、以及醫師選擇意圖。可加入注意力檢核題，例如「請回想這位評論者是否有健康相關經驗標籤」。

第四步，對照基線與分析。基線方法可定義為僅看評論內容、不顯示評論者資料；以及僅顯示頭像與 ID 的最小匿名版本。比較各條件下信任與選擇意圖是否顯著上升，特別檢驗：1. 高資料豐富度是否能顯著補償匿名性造成的不信任。2. 高評論量是否與資料豐富度產生交互作用，即是否形成「越多評論越像可信專家」或「越多評論越像職業評論者」的雙面效應。3. 正負評是否會改變線索權重，尤其負評是否更依賴健康相關經驗線索。4. 新手與熟手是否有不同路徑：新手可能更受資料豐富度與健康自介影響，熟手可能更受診斷細節影響。5. 健康相關線索是否優於一般社交線索，例如「慢性病經驗」是否比「喜歡運動」更能提升對評論者的認知信任與情感信任。

第五步，補充質化資料。從不同條件中抽取部分受試者進行半結構訪談，詢問他們判斷信任的依據。可使用以下示例問題：「當評論者有很多歷史評論時，你會覺得他更可信，還是更像老手操作者？」「健康相關自介和一般自介哪一種更讓你覺得這個人真的懂醫療？」「在負評中，你會更看重評論內容細節還是評論者資訊？」這些質化結果可用來解釋量化模型中的交互作用。

第六步，成功判準。若以下結果成立，即可視為研究成功：1. 高資料豐富度與高評論量能顯著提升認知信任，且在一定程度上取代身份揭露。2. 健康相關線索比一般社會線索更有效，尤其在高風險醫療選擇情境中。3. 正評較容易受資料豐富度與評論量影響，負評則較依賴診斷細節與經驗相似性。4. 新手與熟手呈現明顯不同的信任形成機制。5. 最終醫師選擇意圖可由「不確定性降低 → 認知信任/情感信任 → 選擇意圖」的路徑顯著預測。

若資源允許，還可延伸到第二階段現場研究：與實際醫療評論平台合作，測試不同評論者資訊呈現模板的點擊率、停留時間與評論採納率，驗證實驗結果是否能外推到真實行為。這將使本研究不只停留在心理實驗，而是能真正轉化為平台設計準則與資訊政策建議。

可信新穎度 — 最接近的真實論文

- How reviewers' profiles affect user's judgment of physicians (63.9% · airiti.AL, 2023) — 增量: 這篇論文主要在探討匿名醫師評價網站中，評論者的身份線索與經驗線索如何影響使用者對醫師的判斷、信任與選擇，重點是「評論者線索 → 醫師評價決策」。你的提案則更進一步把焦點放在「匿名狀態下，評論者資料豐富度與評論量能否作為身份揭露的替代信號來重建信任」，並明確加入健康經驗標籤、評論量、診斷細節、以及新手/熟手分群與仿真介面情境。也就是說，你不

是只看一般社會線索是否有效，而是要比較哪些替代信號能在隱私不揭露下取代身份揭露，研究問題與操弄組合都更細緻。

- Estimating Reviewer Credibility Using Review Contents and Review Histories (63.4% · airiti.AL, 2012) — 區隔明確: 這篇文章聚焦於一般網站中的評論者可信度估計，使用的是評論內容與評論歷史來辨識哪些評論者提供有價值資訊，核心是演算法或資料分析式的「可信評論者辨識」。你的提案則是以匿名醫師評論平台為情境，採受試者實驗來測試不同評論者資料豐富度、評論量與診斷細節如何影響人對評論的信任與醫師選擇意圖，並且加入健康經驗線索與匿名平台設計問題。兩者都談可信度，但你的研究重點是人如何在醫療高風險決策中解讀替代信號，而不是計算誰是可信評論者。
- How Reviewer Profiles and Review Volume in Product Ratings Affect Viewers' Purchasing Intention and Trust (57.3% · airiti.AL, 2018) — 增量: 這篇研究是產品評價情境，操弄的是來源國、大頭照與評論數量，結果聚焦在購買意圖與信任；情境是一般消費品，不是醫療決策。你的提案則以匿名醫師評論為核心，除了評論量與頭像/自介之外，還加入健康/醫療相關經驗、診斷細節與評論者歷史軌跡，並關注認知信任、情感信任、不確定性降低與醫師選擇意圖。也就是說，你保留了部分相似的社會線索設計，但研究對象、風險情境與關鍵自變項都明顯不同。

參考文獻

1. How reviewers' profiles affect user's judgment of physicians
2. The Impact of Online Review Related Credibility on Behavioral Intentions on Online Platform
3. The Effects of Consumer-Generated Media on Vietnamese Travelers' Decision Making-Mediation Analysis of Perceived Credibility and Trust
4. How Reviewer Profiles and Review Volume in Product Ratings Affect Viewers' Purchasing Intention and Trust
5. 推薦システムにおける推奨者提示のためのマルチレベル分析による友人の説得力の予測
6. Evaluation of Trustworthiness of reviews in the online travel community
7. Consumers' Assessment of Clinic Services and its Affecting Factors
8. Examining Factors Related to Acceptance of Telemedicine among Taiwan's Expatriate Workers Living in ShangHai of China
9. Are negative reviews more credible and useful? The moderating effects of negative emotions and product types
10. The Influences of Product Review Credibility and Product Rating Credibility on Browsers' Product Attitudes: An Online Platform of Cosmetics
11. 促進質性研究的品質與可信性
12. Mass Publicity of Chinese Court Decisions: Market-Driven or Authoritarian Transparency?
13. THE EFFECT OF REVIEW CONTENT ON THE ONLINE PLATFORM ON CONSUMER'S PURCHASE INTENTION: THE MEDIATING EFFECTS OF TRUST AND ATTITUDE
14. A Reinforcement Learning Method with Attention Mechanism for Generating English Abstractive Summary of Products - Using Amazon E-Commerce as Examples

15. THE CAUSES AND EFFECTS OF USERS ONLINE ANONYMITY CONCERN
16. Causes and Consequences of Users Online Anonymity Concern
17. Identities Anonymization in Dynamic Social Networks
18. Consumers' trust and privacy concerns in the online auction
19. 新媒體時代的健康傳播：以「健康力智慧健康服務平台」為例
20. A Study on the Persuasive Effect of Online Commenters and Arguments
21. Whose online reviews to trust? Understanding reviewer trustworthiness and its impact on business
22. Impact of Anonymity on Consumers' Online Reviews
23. Toward a more robust theory and measure of social presence: Review and suggested criteria
24. Social Presence on LinkedIn: Perceived Credibility and Interpersonal Attractiveness Based on User Profile Picture
25. Online first impressions: Person perception in social media profiles
26. Profile Photos' Impact in Online Reviews: The Effect of Cultural Differences
27. Risk assessment in e-commerce: How sellers' photos, reputation scores, and the stake of a transaction influence buyers' purchase behavior and information processing
28. Examining the relationship between reviews and sales: the role of reviewer identity disclosure in electronic markers
29. How fakes make it through: the role of review features versus consumer characteristics
30. The effects of review valence in organic versus sponsored blog sites on perceived credibility, brand attitude, and behavioural intentions
31. An examination of negative e-WOM adoption: Brand commitment as a moderator
32. Eight Questions About Physician-Rating Websites: A Systematic Review
33. An Analysis of Online Evaluations on a Physician Rating Website: Evidence From a German Public Reporting Instrument
34. A Changing Landscape of Physician Quality Reporting: Analysis of Patients' Online Ratings of Their Physicians Over a 5-Year Period
35. What Do Patients of Different Medical Illness Say About Their Doctors Online? An Analysis of Online Physician Reviews

病患既有醫療經驗與風險知覺如何調節線上醫師評論的信任形成與醫師選擇？

後設資料

想法編號: seed-domain-1=>3=>1=>1

新穎度: 17.1%

最大相似度: 82.9% (近似於: “How reviewers’ profiles affect user’s judgment of physicians”)

群集: 4

競賽得分: 3 勝

方法論契合度: 3/5

問題陳述

線上醫師評論已逐漸成為病患選擇醫師的重要資訊來源，但現有研究多聚焦於評論本身的正負效價、評論者匿名性或經驗線索是否影響信任，較少深入處理「誰在看評論」這件事。事實上，病患並不是空白的資訊接收者；他們帶著既有的醫療經驗、就醫滿意度、對特定醫師或醫療體系的忠誠、健康焦慮、風險知覺、醫療知識與口碑依賴傾向進入決策情境。這些背景會改變病患對評論者線索的解讀方式：例如，初診且高焦慮的病患可能更依賴身份線索來降低不確定性；慢性病追蹤且對固定醫師有忠誠者，則可能更重視評論與自身經驗是否一致，而非評論者是否具體可識別。另一方面，醫療情境本身也不同，初診、轉診與慢性病追蹤所涉及的風險、資訊缺口與決策成本並不相同，因此「同一則評論」在不同情境下可能完全產生不同的信任效果。

本研究要處理的核心問題，是建立一個能解釋並預測「線上醫師評論中的身份線索、經驗線索與評論效價，如何透過認知信任、情感信任與評論可信度影響醫師選擇意向，且此歷程如何被病患的既有醫療經驗與風險知覺調節」的模型。這個問題之所以重要，是因為醫療決策具有高度不確定性與風險，若平台設計者無法理解不同病患到底需要什麼線索，便可能錯誤地強化匿名、過度揭露身份，或單純增加評分數量卻無助於提升真正可用的信任。更進一步地，本研究可回答一個非常實際但長期未被細緻處理的問題：在什麼病患條件下，匿名評論者反而更可信；在什麼條件下，病患需要更豐富的身份線索、更多經驗脈絡，甚至需要與自身醫療歷程相符的敘事，才能形成有效信任與選擇行動。這不只是線上評論研究，更是健康資訊行為、風險溝通與醫療平台治理的交叉問題。

現有方法

既有研究主要可分為四類。第一類是評論者線索研究，常以匿名性、頭像、ID、評論數、過往經驗數、專業背景等作為自變項，觀察其對信任或評論有用性的影響。這類研究通常採 2×2 或 $2 \times 2 \times 2$ 的實驗設計，能回答「單一線索是否有效」，但較少處理受試者本身的醫療背景差異。第二類是評論效價與可信度研究，探討正評或負評哪一種更有說服力，並以資訊診斷性、情緒喚起或負面偏誤解釋結果。然而這些研究大多把使用者視為平均化的消費者，忽略醫療決策與一般商品決策的本質差異。第三類是醫病信任與忠誠研究，關注病患對醫師、醫院或醫療系統的既有滿意度、忠誠與信任如何影響再就醫或推薦行為，但這些研究通常發生在離線醫療體系脈絡，較少與線上評論平台結合。第四類是健康資訊尋求與風險知覺研究，已指出健康焦慮、主觀風險、疾病嚴重度會影響資訊搜尋深度與來源選擇，但尚未充分整合到評論信任形成模型中。

這些方法的共同限制在於：一、過度關注評論內容或平台設計，忽略病患異質性；二、將信任視為單一構念，而非認知信任與情感信任並存的雙路徑；三、少有研究同時結合不同就醫階段與不同疾病情境，因此外部效度有限；四、即使有分群分析，也多停留在年齡、性別、教育程度等人口統計變項，無法捕捉真正影響醫療評論解讀的心理與經驗背景。換言之，既有方法能回答「評論者有沒有身份線索」，卻不足以回答「哪一類病患在什麼情境下會把這些線索當成可信訊號」。

研究動機

本研究的動機來自一個看似矛盾卻很真實的現象：在醫療資訊不確定性最高的場景裡，使用者未必最信任資訊最多的人，反而可能更信任看起來像「和我一樣」的匿名病友；但在另一種場景裡，匿名反而像可疑訊號，具體身份、長期評論歷史與疾病經驗才是建立信任的關鍵。這表示評論信任不是固定機制，而是由使用者的心理狀態與醫療背景動態決定。若研究仍只把匿名與非匿名做靜態比較，就會錯過最重要的互動效果。

因此，我們需要一個更「病患中心」的框架：不是問評論者是否可信，而是問「在什麼條件下，哪一種線索對哪一類病患最有診斷力」。這個思路的創新之處在於，它把傳統的訊息來源可信度研究，轉化成一種「情境適配」問題。醫療經驗豐富、曾有高滿意度醫病關係、對醫師忠誠較高的病患，往往對負面評論更可能啟動防衛性詮釋；而曾有不良就醫經驗、健康焦慮高、風險知覺高的病患，則可能更依賴評論者的經驗脈絡來降低不確定性。這些差異不只是統計上的調節效果，而是能實際指向平台設計與個人化推薦邏輯。

此外，本研究也希望回應一個更前沿的問題：醫療評論平台是否應該一視同仁地展示評論者資訊？答案可能是否定的。若能辨識病患背景與就醫階段，平台便可設計不同的線索呈現策略，例如對初診者優先揭露評論者經驗摘要與情境相似度，對慢性病追蹤者則強調長期經驗與症狀變化敘事。這種做法比單純增加評論數量更有可能提升真正可用的信任。因此，本研究不僅能補足理論缺口，也能產生具有高度實務性與平台設計價值的成果。

提出方法

本研究提出一個名為「雙層互動信任框架」(Dual-layer Interactive Trust Framework, DITF) 的研究方法，用來解釋病患如何在不同醫療背景下，透過評論者線索形成對線上醫師評論的信任，並進一步影響醫師選擇。這個方法的核心思想是：評論信任不是單純由評論內容決定，而是由「評論者層」與「使用者層」兩層訊號共同建構。評論者層包含身份線索、經驗線索與評論效價；使用者層則包含疾病經驗、就醫滿意度、醫師忠誠、風險知覺、健康焦慮、醫療知識與口碑依賴程度。兩層訊號在特定就醫階段與疾病情境中互動，進而影響認知信任、情感信任、評論可信度與選擇意向。

第一步，建立情境化評論刺激庫。研究不使用單一通用醫師評論，而是設計三種醫療情境：初診、轉診與慢性病追蹤。每種情境再搭配兩到三種疾病類型，例如高風險但常見的慢性病、症狀模糊但決策成本高的專科就診、以及需轉診的複雜情境。每則評論刺激會系統性操縱三個來源線索：身份線索（匿名、半匿名、具象化但仍保護隱私的身分提示，如年齡區間、就醫年資、患者角色標記）、經驗線索（是否有相關疾病歷史、是否持續評論同一科別、是否有多次就醫紀錄）、評論效價（正評、負評、混合評）。這些線索不只是單獨出現，而是被設計成不同的「可信敘事包」。例如，匿名高、經驗高、負評的評論，可能在某些高風險情境下反而更像「冒著風險講真話」；而具體身份高、經驗低、正評的評論，則可能在低風險情境下更容易被視為廣告式好評。

第二步，建構使用者背景測量模組。受試者除填答基本人口統計外，還需回答過往就醫經驗、最近一年與特定科別的互動次數、對過去醫師的滿意度、是否存在長期固定醫師、健康焦慮量表、主觀風險知覺量表、醫療知識自評、以及口碑依賴傾向。特別的是，本研究將「醫師忠誠」拆成兩種形式：關係忠誠（對固定醫師的情感與依附）與制度忠誠（對特定醫院或醫療體系的信任）。這樣可更細緻地解釋病患在面對評論時，是在尋找替代方案，還是在驗證既有選擇。

第三步，採用分段式情境實驗。每位受試者先被隨機分派至某一疾病情境，再進入一連串評論判斷任務。每個任務中，受試者觀看一組醫師評論卡片，卡片的來源線索與效價被操縱，並要求受試者完成四個判斷：一、對評論者的認知信任；二、對評論者的情感信任；三、對評論可信度；四、對該醫師的選擇意向。為了避免單次評估過於抽象，本研究加入「二階段選擇」：先讓受試者選擇願意點開哪則評論，再根據閱讀結果選擇是否預約該醫師。這能模擬真實搜尋行為，也能區分「注意」與「採納」兩個不同層次。

第四步，引入反直覺的設計：評論者相似性操弄。除了評論者本身線索外，系統會在部分條件下呈現「病患與評論者的疾病背景相似度」，例如同為初診、同樣是慢性追蹤、或同樣有過轉診經驗。假設

匿名評論者在高風險且高相似情境下更容易被視為真誠，而具體身份評論者在低風險且低相似情境下更像專業或可驗證來源。這一設計使研究能測試一個更大膽的假說：不是身份線索本身決定信任，而是身份線索是否足以支撐「我能把這個人當作與我處境相似的見證者」的想像。

第五步，分析策略採用多層次結構方程模型與潛在類別分析。先用多群組 SEM 檢驗不同情境下的路徑差異，再用潛在類別分析辨識病患是否可分成幾種信任型態，例如「高焦慮、低忠誠、證據依賴型」、「高忠誠、低風險、穩定依附型」、「高經驗、高懷疑、反廣告型」。接著比較不同類別在匿名、經驗線索與效價上的偏好是否不同。最後以離散選擇模型估計哪種線索組合最能提升醫師選擇意向。若資源允許，還可加入簡短開放式回答，透過文本分析理解受試者到底如何語言化自己的信任判斷，進一步補強量化結果。

這套方法最大特色在於，它不把匿名性視為單純的有或無，而把它當作一種可調節的信任距離；也不把病患背景當成背景變項，而是當成改變評論解碼方式的核心機制。最終，研究將產出一個可用於平台設計與健康資訊介面最佳化的互動模型，並可延伸成個人化評論排序與線索呈現規則。

實驗計畫

第一階段：前導研究與刺激材料建置。先進行 15–20 位病患訪談，涵蓋初診、慢性病追蹤與轉診情境，確認哪些醫療背景與評論線索最能引發信任判斷。接著蒐集真實醫師評論文本，將其改寫為標準化刺激卡片，並由專家小組與病患代表共同檢核是否自然、可信且情境相符。每張卡片控制字數、語氣與資訊量，避免非預期變異。這一步也要建立操弄檢核題，確認受試者確實感知到匿名程度、經驗深度與正負評價的差異。

第二階段：正式實驗招募。目標樣本建議至少 300–500 人，且需涵蓋不同年齡層、不同慢性病經驗、不同就醫頻率者。受試者來源可結合醫療社群、健康資訊平台、病友團體與一般網路樣本，並以配額方式確保三種情境的樣本足夠。實驗採線上情境問卷形式，每位受試者隨機分派到一種疾病情境，然後依序閱讀 6–8 則評論刺激，並完成信任與選擇測量。為避免疲勞，可使用拉丁方平衡刺激順序。

第三階段：測量工具與變項。依變項包含認知信任、情感信任、評論可信度、醫師選擇意向，以及點擊 / 選擇行為。自變項為評論者身份線索、經驗線索、評論效價與評論者—使用者相似度；調節變項為疾病經驗、就醫滿意度、醫師忠誠、風險知覺、健康焦慮、醫療知識與口碑依賴程度。可加入中介分析，檢驗評論可信度是否為信任與選擇意向之間的中介。若加入開放式回答，則可作為補充質性證據。

第四階段：基準模型與比較方法。基本基線包括：只用評論效價預測選擇的簡單模型、只用評論者線索的主效應模型、以及不納入病患背景的傳統 SEM。進階比較模型則包括分群迴歸、一般化線性混合模型與潛在類別模型。若要做預測，可比較邏輯斯迴歸、隨機森林與梯度提升樹在預測選擇意向上的表現，但研究重點仍是解釋性。評估指標方面，SEM 檢視 CFI、TLI、RMSEA、SRMR 與路徑顯著性；分類模型可用 AIC、BIC、輪廓係數與類別可解釋性；預測模型則可用 AUC、F1、準確率與校準誤差。

第五階段：成功判準。若研究結果顯示：一、病患背景對匿名性、經驗線索與效價的效果有顯著調節；二、認知信任與情感信任在不同情境下扮演不同中介角色；三、至少能辨識出兩到三種具有明確行為特徵的病患信任類型；四、某些情境下匿名評論者確實比具體身份評論者更可信，而另一些情境則相反，則代表研究成功。更理想的結果是，模型能明確指出平台設計規則，例如「高健康焦慮、初診、低醫療知識者偏好具體身份與經驗線索；高醫療知識、慢性病追蹤者更能接受匿名但高經驗密度評論」。這種結果不僅能支持理論建構，也可直接轉化為醫療評論平台的個人化資訊呈現策略，形成具備國際發表潛力的研究貢獻。

可信新穎度 — 最接近的真實論文

- How reviewers' profiles affect user's judgment of physicians (82.9% · airiti.AL, 2023) — 高度重疊：這篇研究主要比較的是評論者的身份與經驗線索如何影響使用者對醫師的判斷、信任與選擇，重點在「評論者資料本身」的效果。你的提案不只加入評論線索，還明確把病患既有醫療經驗、就醫滿意度、醫師/制度忠誠、健康焦慮、風險知覺與醫療知識納入調節模型，並區分初診、

轉診與慢性病追蹤等情境，去檢驗同一則評論在不同病患與情境下如何改變認知信任、情感信任與選擇意向。(相似度 83% 偏高，標籤經相似度守衛下修)

- What Makes Helpful Online Reviews to the Formation of Trustworthiness? An Experimental Study on the Effectiveness of Review Arrangement across Products (58.7% · airtiti.AL, 2011) — 增量: (模型未提供差異說明；以相似度為準)
- How Reviewer Profiles and Review Volume in Product Ratings Affect Viewers' Purchasing Intention and Trust (58.6% · airtiti.AL, 2018) — 增量: (模型未提供差異說明；以相似度為準)

參考文獻

1. How reviewers' profiles affect user's judgment of physicians
2. The Study of Relationship Between Breast Cancer Patients' Trust and Evaluation toward Physician
3. The Relationship among Trust, Satisfaction and Loyalty in Professional Medical Services: The Case of Taiwan
4. The Study of Relationships between College Student's Cognitions on Levels of Care and Choice Behaviors of Health Care Institutions
5. Word-of-Mouth Effects on Hospital Choice and Moderator Variables
6. A Bayesian Statistical Model Based Outpatient Department Decision Support
7. The Influences of Product Review Credibility and Product Rating Credibility on Browsers' Product Attitudes: An Online Platform of Cosmetics
8. Are negative reviews more credible and useful? The moderating effects of negative emotions and product types
9. When Less Is More: The Persuasive Superiority of Text Reviews for Text-Based Experiential Products
10. How Trust-Assuring Arguments Affect Consumer Trust in Group-Buying Website through the Central Route and the Peripheral Route: The Perspective of Elaboration Likelihood Model and the Moderating Effect of Perceived Price
11. Media Credibility Research: Origin, Development, Opportunity, and Challenges
12. The Impact of Online Review and Price on Hotel Booking Intention at Online Travel Agency: Trust as a Mediating Variable
13. The Effects of Negative Online Reviews and Seller's Feedback on Consumer Purchase Intention
14. Investigating the Structural and Textual Characteristics of Internet Physicians Review
15. The Impact of Promotion Program on Physicians' Choice Behavior
16. The Influences of Characteristics of Medical Institutions and Physicians on Physicians' Choice of Surgical Methods of Intracranial Aneurysms

17. The Effects of Experience Clues on Tourism Experience 、Repurchase Intention and Revisit Intention - A Case Study of Maokong Tour Bus
18. Risk Communication on the Annuity Reform Issue: Applying Situational Theory to the Public to Examine Public Risk Perceptions, Communication Behaviors, and Propensity to Support Policies
19. The Impact of Driving Behavior Risk Perception, Aberrant Driving Behavior and UBI Involvement on UBI Purchase Intention
20. The Impact of Information Quality and Perceived Risk on the Adoption of Google Reviews
21. Longitudinal Analysis of Online Consumer Reviews
22. The Effect of Perceived Value of Online Travel Reviews on Tourists Purchase Attitudes
23. Internet Use Motivations, Perceived Credibility of Online Information, and Decision-Making
24. Whose online reviews to trust? Understanding reviewer trustworthiness and its impact on business
25. Impact of Anonymity on Consumers' Online Reviews
26. Toward a more robust theory and measure of social presence: Review and suggested criteria
27. Social Presence on LinkedIn: Perceived Credibility and Interpersonal Attractiveness Based on User Profile Picture
28. Online first impressions: Person perception in social media profiles
29. Profile Photos' Impact in Online Reviews: The Effect of Cultural Differences
30. Risk assessment in e-commerce: How sellers' photos, reputation scores, and the stake of a transaction influence buyers' purchase behavior and information processing
31. Examining the relationship between reviews and sales: the role of reviewer identity disclosure in electronic markers
32. How fakes make it through: the role of review features versus consumer characteristics
33. The effects of review valence in organic versus sponsored blog sites on perceived credibility, brand attitude, and behavioural intentions
34. An examination of negative e-WOM adoption: Brand commitment as a moderator
35. Eight Questions About Physician-Rating Websites: A Systematic Review
36. An Analysis of Online Evaluations on a Physician Rating Website: Evidence From a German Public Reporting Instrument
37. A Changing Landscape of Physician Quality Reporting: Analysis of Patients' Online Ratings of Their Physicians Over a 5-Year Period
38. What Do Patients of Different Medical Illness Say About Their Doctors Online? An Analysis of Online Physician Reviews

醫師評價平台治理透明度如何形塑制度信任、評論信任與醫師選擇意向？

後設資料

想法編號: seed-domain-2=>2=>1=>3

新穎度: 23.6%

最大相似度: 76.4% (近似於: “How reviewers’ profiles affect user’s judgment of physicians”)

群集: 2

競賽得分: 2 勝

方法論契合度: 2/5

問題陳述

醫師評價平台已經成為民眾尋找醫療資訊、比較醫師與形成就醫決策的重要管道，但這類平台的信任問題遠比一般商品評論複雜。原因在於：病患面對的不只是「評論是否真實」，而是「平台是否值得相信」、「評論者是否可靠」、「醫師回應是否被公平呈現」、「爭議是否有被處理」以及「平台是否持續更新與維護」。在醫療場域中，匿名評論一方面保護隱私，另一方面也增加造假、報復性評論、商業操作與選擇偏誤的疑慮，因此平台常透過各種治理與透明設計來修補信任，例如評論驗證機制、利害關係揭露、編輯歷程、申訴流程、醫療機構回應可見度、資訊更新頻率等。然而，目前研究多半聚焦於評論者個人層次的可信度、評論效價或來源線索，較少把平台治理視為一個獨立的制度性訊號，更少系統性檢驗它如何從「評論者可信度」一路傳導到「平台可信度」與「醫師選擇意向」。這造成理論上與實務上的缺口：我們知道匿名會影響信任，但不知道透明治理能否補償匿名所帶來的不信任；我們也知道使用者會看星等與文字內容，但不知道當平台提供可驗證、可追溯、可申訴的機制時，使用者是否會把信任從個別評論者轉移到整個平台制度。此研究的重要性在於，它不只回答「人們信不信某則評論」，而是回答「人們願不願意把醫療決策建立在一個被治理過的平台上」。若能釐清透明度與治理機制如何降低匿名評論的不確定性，將可為醫療評價平台的介面設計、內容審核政策、法規監理與數位健康資訊素養提供具體依據，也可補足資訊行為、平台治理與信任研究之間的斷裂。

現有方法

既有研究大致可分成四類。第一類是以評論者來源可信度為核心的研究，透過頭像、身份資訊、評論歷史、專業標籤等社會線索，分析其對感知信任、評論有用性與選擇意向的影響。這類研究的優點是能捕捉使用者對「人」的判斷，但限制是把平台當成中性載體，忽略平台本身也在治理資訊流。第二類是評論內容與 eWOM 研究，常比較正負評、雙面評論、具體性、圖片、數量與平均分數，解釋評論是否具有說服力。問題在於它們重內容、輕制度，無法回答當評論本身匿名且品質不一時，平台的驗證與申訴機制是否能提高整體信任。第三類是一般網站可信度與資訊透明度研究，例如電子商務網站的資訊披露、公司治理揭露、網站可信度量表等，這些研究已經指出揭露與透明能提升信任，但多數場景是購物網站或企業網站，未直接對準醫療評論平台這種兼具高風險、強倫理與多利害關係人的環境。第四類是醫療決策與醫療品質資訊公開研究，關注民眾如何利用醫療資訊做選擇，但常把醫療品質視為既定資訊，而不是把平台治理設計視為影響資訊解讀的前置條件。這些方法的共同限制是：一是多半單獨分析某一層次，缺少「評論者—平台—醫師」的串聯模型；二是多以靜態問卷或單一實驗操弄為主，較少同時比較不同平台的治理差異；三是很少考慮制度透明度在匿名評論環境下的補償效果，也缺乏對爭議處理、更新頻率、醫療機構回應可見度等治理元素的細緻操作。

研究動機

本研究的出發點是：在醫療評論情境中，使用者其實不是在評估單一訊息，而是在評估一整套「可信任的資訊生產制度」。這意味著匿名未必必然導致低信任，因為匿名性若與高透明治理配套，可能反而形成一種「受監督的匿名」。這個想法對現有研究是一個重要的反轉：過去大家多把匿名當成風險，但在醫療情境中，真正決定信任的可能不是匿名本身，而是匿名之下是否存在可追溯、可申訴、可校正的制度。這也是為什麼單靠評論者頭像或 ID 設計不足以解釋醫師選擇行為，因為使用者可能會先問：「這平台怎麼知道這些評論不是假的？」再問：「即使有假評論，平台會不會處理？」因此，本研究提出把平台治理透明度視為一種「制度性可信度線索」，它不直接等同於內容品質，而是作為一個更高層次的信任框架，調節並重構使用者對評論者可信度的判斷。這樣的設計也更貼近真實世界：醫療平台不只是展示評論，而是在治理、審核、揭露與回應中不斷建構其正當性。若能證明透明治理能在匿名評論存在時仍維持高信任，便可為平台設計提供實務上極具價值的指引；反之，若某些治理機制反而造成使用者警覺或認知負擔，也能提醒平台避免「透明過度」導致信任稀釋。換言之，本研究的創新不是再做一次評論可信度研究，而是把平台治理當作信任基礎設施來研究。

提出方法

本研究提出一個「評論者可信度—平台治理可信度—醫師選擇」的串聯模型，並以「治理透明度矩陣」作為核心研究工具。整體方法採混合式設計，包含三個互補模組：平台治理內容分析、介面準實驗、以及情境式問卷與選擇實驗。第一，先建構「醫師評價平台治理透明度矩陣」。研究將蒐集台灣與國際醫師評價網站、健康論壇、掛號/評價整合平台的公開介面與政策頁面，系統性編碼六種治理線索：評論驗證機制（是否以就醫紀錄、掛號紀錄、手機驗證或機構驗證確認身分）、利害關係揭露（是否標示是否為患者、家屬、合作關係、贊助關係）、評論修改歷程（是否提供編修紀錄、時間戳、刪改原因）、爭議申訴流程（是否公開申訴入口、處理時程、判定標準）、醫療機構回應可見度（是否顯示醫院/醫師回覆、回覆排序與完整性）、資訊更新頻率（評論更新、資料更新、醫師異動更新）。這一步不只是描述性比較，而是用來抽取平台的治理型態，形成高透明、高治理 / 低透明、低治理等原型。

第二，設計「制度線索介面操弄」。研究將製作一個高擬真醫師評價平台原型，以同一位虛構醫師、同樣星等與評論內容為基礎，僅改變治理線索。操弄不再只放大匿名與身份，而是把平台頁面中的治理元件做成可見的制度訊號。例如：高治理版會顯示「評論已透過就診驗證」、「存在利益關係揭露欄位」、「評論可查看修訂記錄」、「可點擊申訴並看到平均處理天數」、「醫療機構回應顯示在評論下方」、「資料最近更新於昨日」；低治理版則僅提供基本評論與星等。為了增加創意與真實性，可加入一個「平台治理儀表板」，像金融平台的風險標籤一樣，將評論的制度可信度轉譯成可視化指標，例如「驗證率」、「爭議處理透明分數」、「回應可見度」、「更新新鮮度」。這個儀表板不是直接告訴使用者該信什麼，而是讓使用者看到平台如何治理信任。

第三，建立串聯心理模型。理論上，研究假設使用者會先根據評論者線索形成「評論者可信度」，再據此推論平台是否值得信任；但平台治理線索也可能反向作用，當平台顯示高治理透明度時，使用者會提高對評論者資訊的容忍度與整體信任，進而提升醫師選擇意向。因此模型將包含三個層次：評論者可信度（認知信任、情感信任、真實性感知）→ 平台治理可信度（制度正當性、程序公平感、可問責性感知）→ 醫師選擇意向（預約、詢問、收藏、分享給家人）。此外，研究將考慮匿名性與治理透明度的交互作用，特別測試「透明度是否能補償匿名」。也就是說，在高匿名條件下，如果治理線索足夠強，平台可信度是否仍能維持，甚至超越低治理的具名平台。

第四，加入一個更大膽但可行的創新：設計「爭議情境注入」模組。研究不只看一般評論，還會操弄平台是否存在爭議案例，例如某則差評被醫師申訴、平台如何顯示申訴進度、是否保留原文與更正說明、是否標註被檢舉原因。此舉可測試使用者在面對風險訊號時，是否更依賴平台治理而非單一評論者。這個模組能模擬真實世界中最常見也最敏感的問題：病患負評究竟是揭露不良服務，還是情緒性報復？平台若公開申訴處理歷程，是否反而增加信任？

第五，資料分析採多層次模型與中介/調節中介分析。先以確認性因素分析驗證「評論者可信度」與「平台治理可信度」是否為不同構念，再用結構方程模型檢驗串聯關係；若採選擇任務，可進一步用離

散選擇模型或層級貝葉斯模型分析使用者在多個醫師/平台方案間的偏好。創意上也可加入「信任轉移」概念：觀察使用者是否從對評論者的信任轉向對平台制度的信任，並判斷哪一種信任更能預測最終醫師選擇。若結果支持，高治理平台會讓匿名評論的負面效果顯著減弱，代表平台透明度不是附屬設計，而是醫療資訊基礎設施的一部分。

實驗計畫

第一步，平台樣本蒐集與治理編碼。先建立台灣與國際醫師評價平台樣本，包含獨立醫師評論站、醫療入口網站、掛號平台的評論功能頁、以及有回應機制的健康社群。制定治理透明度編碼手冊，由兩位以上編碼者獨立標註六項治理線索，計算 Krippendorff's alpha 或 Cohen's kappa。輸出一份「醫師評價平台治理透明度指數」與平台類型圖譜，作為實驗刺激設計依據。

第二步，刺激材料製作與前測。根據治理指數選取兩至三個代表性平台樣式，製作擬真原型頁面。每個頁面都使用相同醫師背景、相同評論內容、相同星等，僅操弄治理透明度高低、匿名程度高低，以及是否有爭議申訴情境。進行前測確認參與者能正確辨識操弄，並確認頁面在視覺複雜度、資訊量與可讀性上盡量一致，避免混淆。

第三步，主實驗一：介面準實驗。招募近期有使用醫療評論或網路查詢醫師經驗的受試者，採組內或混合設計，讓受試者依序瀏覽不同治理版本的平台頁面。蒐集評論者可信度、平台可信度、程序公平感、風險感知、醫師選擇意向等量表資料。建議量表可改編自來源可信度、網站可信度、制度信任與醫療決策意向文獻。評估指標包括：信任總分、各構念因素負荷、串聯中介效應、匿名性與治理透明度的交互作用、以及是否存在「高透明補償效應」。

第四步，主實驗二：情境式離散選擇實驗。設計多組醫師選擇情境卡，讓受試者在兩至三位虛構醫師間做選擇，每位醫師掛載不同平台治理條件。透過選擇任務估計各治理線索的相對重要性，例如驗證機制、申訴流程、醫療機構回應可見度、資訊更新頻率哪一項最能提升被選擇機率。此步驟能把心理態度轉換為接近真實決策的行為資料。

第五步，補充性質化訪談。從高信任與低信任受試者中抽樣進行半結構式訪談，追問其如何理解「平台透明」與「可信任評論」之間的關係，例如是否認為公開申訴代表平台中立、是否把醫療機構回應視為防禦性操作、是否把更新頻率當作專業維護信號。此步驟可解釋量化結果背後的認知機制，並挖掘意料之外的信任反應。

第六步，資料分析與成功判準。若高治理透明度能顯著提升平台可信度，並透過平台可信度中介提升醫師選擇意向，且在匿名條件下仍維持或強化效果，即可視為核心成功。若爭議申訴與修改歷程等「可問責性」線索比單純揭露更能提升信任，則代表本研究的重要理論貢獻成立：使用者信任的不是「看起來很透明」的平台，而是「可被追責、可被校正」的平台。若結果顯示某些線索在高風險醫療情境中反而降低信任，也能產生有價值的反直覺結論，指向透明度設計需平衡資訊負荷與制度可理解性。最終產出除了論文外，還可形成一套醫師評價平台治理設計建議與公開評估框架，供平台業者、醫療機構與政策制定者參考。

可信新穎度 — 最接近的真實論文

- How reviewers' profiles affect user's judgment of physicians (76.4% · airiti.AL, 2023) — 高度重疊：這篇論文主要是在匿名醫師評價網站情境下，操弄的是「評論者的身份與經驗線索」如何影響對單則評論、評論者可信度與醫師選擇；本研究則把焦點放在「平台治理透明度」本身，系統性檢驗驗證機制、利害關係揭露、修訂歷程、申訴流程、醫師回應可見度與更新頻率如何形成制度性信任。方法上，本研究不只做評論者線索實驗，還加入平台治理內容分析、治理透明度指數建構，以及介面準實驗與離散選擇實驗，因此研究問題與理論層次都明顯高一層，並不只是評論者層次的延伸。（相似度 76% 偏高，標籤經相似度守衛下修）
- The Impact of Online Review Related Credibility on Behavioral Intentions on Online Platform (66.3% · airiti.AL, 2017) — 增量：這篇研究是一般電商評論情境，重點在評論可信度、評論者可信度與評論機制可信度如何影響對網路商家與平台的信任，以及行為意圖；本研究則限定在醫

師評價平台，且關注的是醫療決策中的制度信任、評論信任與醫師選擇意向，特別納入醫療場域特有的治理透明度與醫師／醫療機構回應可見度。它沒有處理醫療平台的治理設計、匿名評論的醫療倫理與申訴機制，也沒有把「平台治理透明度」當作獨立自變項來檢驗。

- Enhancing the Credibility and Transparency of Academic Peer Review Using Blockchain and Reviewer Quality Control Mechanisms (58.7% · airtiti.AL, 2025) — 區隔明確: 這篇論文談的是學術同行評審的透明化，透過區塊鏈與審查者品質控管來提升審查流程可驗證性，研究對象是論文審查制度，而不是醫師評價平台與一般使用者的選擇決策。你的提案雖然同樣關注透明度與信任，但研究場域、制度對象與方法都不同：你不是建構審查系統，而是分析與操弄醫師評價平台的治理線索，並測量使用者對平台與醫師選擇的影響。

參考文獻

1. How reviewers' profiles affect user's judgment of physicians
2. The Study of the Effects of Source Credibility of Word-of-Mouse, Consumers' Trust and Involvement on Purchase Intention
3. The Influences of Product Review Credibility and Product Rating Credibility on Browsers' Product Attitudes: An Online Platform of Cosmetics
4. The Effects of Corporate Governance and Information Disclosure and Transparency Ranking System on Intellectual Capital Disclosure: Evidences from Listed Electronic Firms in Taiwan
5. The Degree of Information Disclosure, Cash Holding and Firm Value
6. Conformity or Uniqueness? The Impacts of Social Influence on Online Product Rating
7. A Study of Factors Affecting Behavioral Intentions with Using Cloud Healthcare Management System Platform - The Example of Health Automatic Teller Machine (HATM)
8. A Bayesian Statistical Model Based Outpatient Department Decision Support
9. A Relevance Study of Consumers Behavior and Consciousness for Disclosing Medical Care Quality Information
10. Development of a Scale for Measuring the Source Credibility of on-Line Word-of-Mouth
11. This is NOT a Sponsored Review: The Effect of Non-Sponsorship Disclosure On Source Credibility of Online Product Opinions
12. The Influence of eWOM Source Credibility on Purchase Intention of Travel Products
13. D2C-WEB CRED: A Comprehensive Instrument to Measure the Credibility of Direct-to-Consumer Brand Websites
14. Exploring image in language concreteness reviews and two-sided reviews on online review helpfulness
15. An Investigation of Online Review Sidedness Effect
16. Exploring the Intention to Continuous Usage of Over-The-Top Platform Based on Unified Theory of Acceptance, and Use of Technology 2 and Trust - A Case Study of Netflix

17. Sharing Economy Airbnb Trust and Sustainable Use Intention
18. Effects of Electronic Word-of-Mouth Messages on Consumers' Trust
19. Explore the Influencing Community Trust of Facebook on Purchase Intention — The Mediation Effect of Online Word-of-Mouth and Message Trust
20. The Antecedents of Electronic Word-of-Mouth: An Empirical Study on the Famous Website in Taiwan
21. XFlag: explainable fake news detection model on social media
22. Antecedents of Online Review Helpfulness in the Gourmet Food
23. A Semi-Supervised Deep Learning Model for Fake Review Detection
24. The Impact of Online Review Related Credibility on Behavioral Intentions on Online Platform
25. Media Credibility Research: Origin, Development, Opportunity, and Challenges
26. The Effects of Electronic Word-of-Mouth and Product Information Quality on Brand Trust: The Application of the Elaboration Likelihood Model
27. Real Name Verification Policy on the Internet : Controversy over the Legal Issues
28. The Effects of Website Characteristics and Relationship Investment on Online Trust and Loyalty
29. A Study on Continuous Adoption Intension of Online Financial Service -The Mediating Effect of Trust about Web sites
30. The Study of Relationship Between Breast Cancer Patients' Trust and Evaluation toward Physician
31. Whose online reviews to trust? Understanding reviewer trustworthiness and its impact on business
32. Impact of Anonymity on Consumers' Online Reviews
33. Toward a more robust theory and measure of social presence: Review and suggested criteria
34. Social Presence on LinkedIn: Perceived Credibility and Interpersonal Attractiveness Based on User Profile Picture
35. Online first impressions: Person perception in social media profiles
36. Profile Photos' Impact in Online Reviews: The Effect of Cultural Differences
37. Risk assessment in e-commerce: How sellers' photos, reputation scores, and the stake of a transaction influence buyers' purchase behavior and information processing
38. Examining the relationship between reviews and sales: the role of reviewer identity disclosure in electronic markers
39. How fakes make it through: the role of review features versus consumer characteristics

40. The effects of review valence in organic versus sponsored blog sites on perceived credibility, brand attitude, and behavioural intentions
41. An examination of negative e-WOM adoption: Brand commitment as a moderator
42. Eight Questions About Physician-Rating Websites: A Systematic Review
43. An Analysis of Online Evaluations on a Physician Rating Website: Evidence From a German Public Reporting Instrument
44. A Changing Landscape of Physician Quality Reporting: Analysis of Patients' Online Ratings of Their Physicians Over a 5-Year Period
45. What Do Patients of Different Medical Illness Say About Their Doctors Online? An Analysis of Online Physician Reviews

醫療評論平台的信任基礎建設：自我效能、制度信任與專業可信度如何共同影響醫師評論採納

後設資料

想法編號: seed-domain-1=>1=>1=>3

新穎度: 27.2%

最大相似度: 72.8% (近似於: “How reviewers’ profiles affect user’s judgment of physicians”)

群集: 3

競賽得分: 2 勝

方法論契合度: 2/5

問題陳述

線上醫師評論已成為民眾選擇醫師的重要資訊來源，但醫療情境與一般商品評論不同：醫療決策涉及高風險、專業不對稱、隱私敏感與情緒壓力，因此使用者並不只是判斷評論內容是否有用，而是在同時判斷「這個人不可信」、「這個平台是否可靠」、「我自己是否有能力理解與篩選」以及「這些資訊會不會反而讓我暴露風險」。現有研究多聚焦在評論者匿名性、評論效價、評論數量或來源可信度等單一訊號，但較少把使用者的健康資訊自我效能納入核心模型。這是一個關鍵缺口，因為同樣的評論線索，對高自我效能者可能只是輔助資訊，對低自我效能者卻可能是焦慮、依賴或逃避的觸發器。若平台只強調匿名保護，可能提升隱私感卻降低專業信任；若只強調醫師背景與驗證標章，可能增加制度信任卻造成資訊過載或冒牌專業的反效果。因此，本研究要處理的核心問題不是「評論是否有用」，而是「醫療評論採納的信任基礎如何被建構、被放大、或被破壞」。這個問題重要且具創新性，因為它直接關聯到數位健康素養、平台治理、病人賦權與醫療資訊中介機制，也能回應台灣在健保制度、醫療可近性與高密度就醫環境下，民眾如何在大量可得資訊中做出醫師選擇的實際難題。

現有方法

既有方法大致可分為三類。第一類是線上評論效果研究，常以評論數量、星等、正負向、長度、具體性、兩面性或評論者歷史作為自變項，觀察其對有用性、可信度或購買意向的影響；這類研究能解釋一般消費情境，但對醫療高風險決策的特殊性處理不足。第二類是來源可信度與社會訊息處理理論的研究，將評論者身份、經驗、專業背景或匿名性視為線索，驗證其對信任與採納意圖的作用；但這些研究通常把「評論者」當成唯一焦點，忽略平台制度與使用者能力。第三類是科技接受模式、信任模型或隱私風險模型，常用於健康網站、電子病歷、線上銀行或知識庫系統，強調自我效能、制度信任、感知風險與使用意圖；然而這些研究多聚焦「使用系統」而非「採納評論」，也很少將「評論者資訊線索」與「醫師選擇決策」整合到同一模型。傳統實驗法雖可操弄匿名性、正負評或專業標籤，但通常只看短期態度變化，較難解釋使用者在真實就醫前如何整合多種信號。總體而言，現有方法的限制在於：變項切得太碎、情境太單一、缺乏平台層與個體層的交互視角，因而不足以建構可供平台設計與公共治理使用的完整信任模型。

研究動機

本研究的動機來自一個看似簡單、其實很詭異但真實存在的現象：同一則醫師評論，有人看了就預約掛號，有人看完只會更焦慮，還有人因為「太像真人講話」反而更不信任。這表示醫療評論的採納不是單靠內容品質，而是由三種基礎共同支撐：第一，個體是否有足夠的健康資訊自我效能去理解與篩選；第二，平台是否提供可被相信的制度保證，如驗證、隱私保護、反舞弊機制；第三，評論與評論者是否具

備專業可信度與可辨識的經驗線索。既有研究往往只取其中一角，結果導致平台設計建議過於粗糙，例如「增加驗證標章」或「讓評論者更匿名」這些做法可能彼此衝突，甚至對不同類型使用者產生相反效果。我的核心假設是：醫療評論平台真正需要的不是單一的高信任元素，而是一套「可調式信任架構」——讓高自我效能者得到更完整的專業與證據線索，讓低自我效能者得到更強的安全感與引導，讓所有人都能在不過度暴露隱私的前提下，理解評論來源的可信度。這種設計在理論上能把來源可信度理論、社會臨場感、制度信任與自我效能整合；在實務上則能直接轉化為平台的資訊排序、驗證機制、風險提示與介面分層，預期會比單純檢驗評論效價或匿名性更能解釋實際就醫行為。

提出方法

本研究提出一個名為「分層信任—醫療評論採納模型」(Layered Trust Adoption Model, LTAM) 的研究架構，目標是同時解釋：使用者如何形成對評論的信任、如何將信任轉化為醫師選擇意向，以及如何進一步影響實際就醫行為。此模型結合三個層次。

第一層是個體層：健康資訊自我效能。定義為使用者蒐集、理解、比較與應用健康資訊的能力感受。此變項不只是控制變項，而是核心分群變項，因為高自我效能與低自我效能使用者在面對評論者匿名性、醫師背景標示、平台驗證標章時，可能採取完全不同的判讀路徑。

第二層是平台層：制度信任與安全感。這層包含平台是否提供真實身份驗證、評論者歷史一致性檢查、隱私保護說明、資料安全承諾、以及反詐騙/反洗評論機制。此層不只影響對平台本身的信任，也會外溢到對評論內容的認知可信度。

第三層是資訊層：醫療專業可信度與來源線索依賴。這層評估使用者對醫師專業背景、評論者經驗深度、評論具體性、是否有就醫情境細節、是否為正負雙面訊息、以及是否有可驗證線索的依賴程度。這些線索將被拆解成「專業線索」與「社會臨場線索」兩類，並檢驗其交互效果。

方法上採混合研究設計，分三階段進行。

階段一：探索式質性研究。先進行 20 至 30 位受訪者深度訪談，涵蓋高/低自我效能、不同年齡、不同就醫頻率與不同數位素養群體，蒐集其對醫師評論的判讀習慣、隱私焦慮、對匿名/半匿名的接受度、以及對驗證標章與醫師背景資訊的偏好。訪談後以主題分析建立候選構面，避免直接沿用一般電商評論模型。

階段二：情境式實驗與結構方程模式。設計一組可控的醫療評論平台原型，系統性操弄四類資訊線索：評論者匿名程度（高度匿名、半匿名、可驗證但不完全揭露）、平台驗證標章（有/無）、醫師專業背景標示（詳細/簡略）、以及評論內容具體性（高/低）。在此基礎上，加入使用者自我效能分群，形成多組情境。受試者先完成平台瀏覽任務，再填寫信任、隱私安全感、感知專業可信度、評論採納意圖、醫師選擇意向等量表。資料分析上，以結構方程模式檢驗中介路徑：自我效能 → 線索理解能力/風險感知 → 制度信任/專業可信度 → 評論採納 → 醫師選擇意向。再以多群組分析測試高低自我效能的路徑差異。

階段三：接近真實行為的追蹤。針對部分受試者，在實驗後一至兩週追蹤其是否真的搜尋醫師、收藏醫師、比較門診、或完成預約掛號。若可能，與平台合作取得去識別化點擊資料或模擬預約資料，以檢驗「意向」是否能轉化為「行為」。這一步很重要，因為醫療評論研究常止步於態度，而本研究要把「看完有沒有真的去看醫生」納入。

本研究的創新點不在於再做一次評論可信度實驗，而在於把評論採納視為一種分層信任協商：高自我效能者會利用更多專業線索與內容品質來形成判斷；低自我效能者則更依賴平台制度、匿名保護與風險提示。也因此，平台不應只設計單一版本，而應建構可切換的信任介面，例如在高風險情境下優先顯示醫師專業資訊與評論者驗證摘要，在隱私敏感情境下優先顯示匿名保護與資料安全說明，並依使用者特徵動態調整資訊呈現層級。若結果成立，LTAM 不僅可解釋評論採納，也能作為醫療評論平台的設計原則與治理框架。

實驗計畫

第一步，建立研究材料與量表。蒐集台灣常見醫師評論平台的介面元素與評論格式，整理出可操弄的三到四個線索模組：評論者匿名性、平台驗證標章、醫師專業背景標示、評論具體性。同步採用或修訂既

有量表：健康資訊自我效能、制度信任、隱私安全感、來源可信度、專業可信度、評論採納意圖、醫師選擇意向，必要時進行前測與信效度檢驗。

第二步，進行質性前導研究。招募不同年齡與就醫經驗者進行半結構訪談，問題聚焦於：你會相信怎樣的醫師評論？匿名讓你比較安心還是不安心？看到平台驗證標章會更信還是更怕是行銷？你看醫師背景還是先看評論者經驗？分析方式採主題分析與扎根理論式編碼，產出最終模型與實驗情境。

第三步，設計情境實驗。建立一個仿真的醫療評論平台原型，每位受試者依隨機分派瀏覽數個醫師頁面。建議採 2（自我效能：高/低，作為分組）× 3（匿名性：高、半匿名、驗證型）× 2（平台驗證：有/無）× 2（醫師專業標示：詳細/簡略）的混合設計，或以精簡版本控制認知負荷。每個情境都讓受試者完成同樣的決策任務：選出最想預約的醫師、評估評論可信度、估計個資風險。

第四步，蒐集行為與主觀資料。主要資料包括：評論採納分數、醫師選擇意向、信任量表、隱私安全感、決策信心、資訊負荷；若可行，再記錄點擊行為、停留時間、捲動深度、收藏/比較次數等。這些行為資料可作為評論採納的客觀代理指標。

第五步，統計分析。先以驗證性因素分析確認量表結構，再以結構方程模式檢驗路徑關係與中介效果；接著進行多群組分析比較高/低自我效能者的模型差異；若使用實驗資料，則進行交互作用檢驗，觀察匿名性、驗證標章與專業標示對不同群體的效果。若包含追蹤資料，則以羅吉斯迴歸或離散時間事件分析檢驗評論採納是否預測真實就醫行為。

第六步，設定成功標準。若模型成立，應觀察到：1）健康資訊自我效能正向影響評論採納，且透過專業可信度與信任中介；2）平台制度信任與隱私安全感顯著提升對評論與平台的整體信任；3）高自我效能者較依賴專業背景與評論具體性，低自我效能者較依賴驗證標章與匿名安全感；4）評論採納能顯著預測醫師選擇意向，並在部分樣本中預測後續實際行為。若結果顯示不同群體對線索有相反反應，將更支持本研究的核心主張：醫療評論平台不能只提供更多資訊，而要提供分層、可調式、兼顧隱私與專業的信任基礎建設。

若資源允許，可加做一個極具爆點的附加實驗：比較「完全匿名」、「半匿名可驗證」、「去匿名但隱私保護」三種平台設計，測試哪一種最能同時提升信任與行為採納。這個設計雖然看似很瘋，但實際上能直接回答平台治理最棘手的問題：在醫療場景裡，匿名到底是保護、障礙，還是兩者兼具。

可信新穎度 — 最接近的真實論文

- How reviewers' profiles affect user's judgment of physicians (72.8% · airiti.AL, 2023) — 增量：本提案不只檢驗匿名性、身份/經驗線索如何影響對醫師與評論者的信任，而是把「健康資訊自我效能」設為核心分群變項，進一步分析高/低自我效能者在面對平台驗證標章、隱私安全感與專業可信度時的不同判讀路徑。方法上也更進一步納入質性前導、仿真平台原型、行為資料（點擊、停留、比較）與實際選醫師意向，並明確把平台治理與隱私風險感納入模型。
- The Impact of Online Review Related Credibility on Behavioral Intentions on Online Platform (60.6% · airiti.AL, 2017) — 增量：這篇主要是以一般電子商務評論脈絡探討評論可信度、評論者可信度與機制可信度如何影響對商家與平台的信任，以及行為意圖；本提案則聚焦在醫療情境，核心不只是「評論是否可信」，而是醫療高風險決策下的專業可信度、制度信任、隱私焦慮與健康資訊自我效能如何共同影響醫師評論採納。相較之下，本提案加入醫療專業線索、醫師選擇任務與平台驗證/醫療背景標示的操弄，研究對象與情境也更明確限定於醫師評論平台。
- Enhancing the Credibility and Transparency of Academic Peer Review Using Blockchain and Reviewer Quality Control Mechanisms (56.0% · airiti.AL, 2025) — 區隔明確：這篇是把區塊鏈與審查者品質控管機制應用於學術同行評審制度，重點在審查流程的透明化、可追溯性與審查者責任治理，屬於系統設計與基礎架構提案。本提案則不是在設計醫療評論平台的技術治理系統，而是在研究一般使用者如何形成對醫師評論的信任與採納，並用情境實驗檢驗匿名性、驗證標章、專業背景標示與自我效能的交互作用。

參考文獻

1. How reviewers' profiles affect user's judgment of physicians
2. Longitudinal Analysis of Online Consumer Reviews
3. Are negative reviews more credible and useful? The moderating effects of negative emotions and product types
4. The Study of Affecting Factors of Internet Bank Actual Behavior
5. The Integration of Self-Efficacy, Trust, Organizational Support, and Personal Motivation to Explore Behavioral Intention of Health Knowledge Repository Systems-an Empirical Study of Teaching Hospital
6. Exploring image in language concreteness reviews and two-sided reviews on online review helpfulness
7. An Investigation of Online Review Sidedness Effect
8. 中國 B2C 線上購物情境下信任的前因與結果
9. Research on the influence of different scales of online celebrity endorsement food source credibility and consumption intention
10. Antecedent and Outcome of Pharmacist Credibility - A Case Study of Taiwan' s Drug Store Pharmacist
11. The Study of the Effects of Source Credibility of Word-of-Mouse, Consumers' Trust and Involvement on Purchase Intention
12. 網路口碑之訊息信任對遊客選擇民宿住宿意願影響之研究—以花蓮地區為例
13. The Effects of Electronic Word-of-Mouth and Product Information Quality on Brand Trust: The Application of the Elaboration Likelihood Model
14. Factors Influencing Patient's Choice of Hospital and Satisfaction with the Ambulatory Service of Seven Chinese Medicine Hospitals in Taichung
15. A Survey of New Hospital Patients on Their Selection of Medical Information Media and Care Providers
16. The Impact of Online Review and Price on Hotel Booking Intention at Online Travel Agency: Trust as a Mediating Variable
17. A Study of the Impact of Consumer Feedback Mechanism for Online Reviews: The Role of Online Review Helpfulness and Online Review Visibility
18. Evaluating the Helpfulness of Online Hotel Reviews
19. 基於情緒模式預測產品評論之幫助性
20. The impact of electronic word-of-mouth: The case of makeup and beauty care.
21. The Influences of Characteristics of Medical Institutions and Physicians on Physicians' Choice of Surgical Methods of Intracranial Aneurysms

22. Factors Affecting Choice of Specialty in Different Level of Physicians
23. The Study of Consumer Behavior After Non-surgical, minimally invasive Cosmetic Treatments -A Study of Customers Receiving Cosmetic Treatments
24. Research on the Factors Influencing the Usefulness of Online Reviews–Mediating Effect based on Online Interaction
25. A study of negativity bias effect of usefulness of word of mouth based on sentiment analysis of actual online customer reviews
26. The Impact of Information Quality and Perceived Risk on the Adoption of Google Reviews
27. The Effect of Perceived Value of Online Travel Reviews on Tourists Purchase Attitudes
28. Internet Use Motivations, Perceived Credibility of Online Information, and Decision-Making
29. Risk Communication on the Annuity Reform Issue: Applying Situational Theory to the Public to Examine Public Risk Perceptions, Communication Behaviors, and Propensity to Support Policies
30. Whose online reviews to trust? Understanding reviewer trustworthiness and its impact on business
31. Impact of Anonymity on Consumers’ Online Reviews
32. Toward a more robust theory and measure of social presence: Review and suggested criteria
33. Social Presence on LinkedIn: Perceived Credibility and Interpersonal Attractiveness Based on User Profile Picture
34. Online first impressions: Person perception in social media profiles
35. Profile Photos’ Impact in Online Reviews: The Effect of Cultural Differences
36. Risk assessment in e-commerce: How sellers’ photos, reputation scores, and the stake of a transaction influence buyers’ purchase behavior and information processing
37. Examining the relationship between reviews and sales: the role of reviewer identity disclosure in electronic markers
38. How fakes make it through: the role of review features versus consumer characteristics
39. The effects of review valence in organic versus sponsored blog sites on perceived credibility, brand attitude, and behavioural intentions
40. An examination of negative e-WOM adoption: Brand commitment as a moderator
41. Eight Questions About Physician-Rating Websites: A Systematic Review
42. An Analysis of Online Evaluations on a Physician Rating Website: Evidence From a German Public Reporting Instrument
43. A Changing Landscape of Physician Quality Reporting: Analysis of Patients’ Online Ratings of Their Physicians Over a 5-Year Period
44. What Do Patients of Different Medical Illness Say About Their Doctors Online? An Analysis of Online Physician Reviews

匿名醫師評論中，評論者身份與文本結構如何共同影響評論可信度與醫師選擇？

後設資料

想法編號: seed-domain-1=>1=>3=>1

新穎度: 19.4%

最大相似度: 80.6% (近似於: “How reviewers’ profiles affect user’s judgment of physicians”)

群集: 5

競賽得分: 2 勝

方法論契合度: 4/5

問題陳述

線上醫師評價網站已逐漸成為病患與家屬做醫師選擇的重要資訊來源，但其核心困境在於：使用者必須依賴陌生人所撰寫、且通常匿名的經驗敘事來判斷醫師品質。匿名設計雖保護隱私，卻也削弱來源可辨識性，使使用者難以判斷評論是否真實、是否具有足夠經驗、是否只是情緒發洩或操弄性內容。既有研究多聚焦於評論者個人資料或評論效價對信任的影響，卻較少系統性處理一個更貼近真實決策情境的問題：當評論者身份線索不足時，使用者會不會轉而依賴評論文本本身的結構與診斷性，例如是否具體描述就診流程、候診時間、溝通內容、治療結果、可驗證細節、前後對照與因果敘事？

這個問題重要且有趣，因為它不只是醫療資訊選擇問題，也是資訊可信度治理問題。若平台只能以星等或簡短心得呈現，使用者可能被情緒化內容牽引；但若能理解「身份線索 × 文本結構」的交互作用，平台就可更精準地設計排序、標記與提醒機制。例如，在匿名評論下，結構完整且具體可驗證的評論是否比短促情緒評論更可信？在負評情境下，是否反而是越匿名、越像「沒有利益動機」的評論者更容易被信任？又或者，當評論者有較豐富的評論歷史與特定專長累積時，文本中的負面敘事是否更能轉化為認知信任而非情緒反感？本研究欲補足這些缺口，建立一個可同時解釋來源線索、文本線索與決策後果的雙層模型，讓匿名醫師評論可信度不再只是單一來源屬性問題，而是可被設計、可被治理、也可被實證檢驗的資訊互動現象。

現有方法

既有方法主要可分為三類。第一類是以來源可信度為核心的研究，常使用評論者頭像、ID、歷史發文數、專業標籤、評分平均值等作為線索，測量使用者對評論者的信任、說服力與採納意願。這類研究的限制在於，它們往往將評論文本視為固定背景，未充分處理文本內容如何補強或削弱來源效果。第二類是以評論內容分析為核心的研究，聚焦文本長度、情緒、可讀性、分段、主題、屬性數量與具體性，透過人工編碼或自然語言處理方法預測評論有用性、可信度或星等。這類研究的限制在於，常把評論當成獨立文本，忽略使用者在閱讀時會同時看見作者資訊，且作者資訊會改變文本被解讀的方式。第三類是以線上口碑與醫療決策為核心的實驗或調查研究，檢驗評論效價、來源專業性與信任對醫師選擇意向的影響，但多半採簡化刺激材料，只操弄正負評與身份有無，缺少對「評論結構診斷性」的精細控制。

此外，現有平台常見的 baseline 機制也有局限，例如只靠星等排序、只顯示最新評論、或依有用票數排序，這些方法容易放大極端情緒、跟風效應與資訊馬太效應，卻無法辨識匿名文本中何者較具證據性。若以傳統資訊檢索或推薦系統方法處理，模型可能只學到語言表層相關性，而非人類對可信度的社會判斷過程。因此，現有研究與實務工具皆不足以回答「匿名醫師評論中，誰在說」與「說得像不像真的就醫經驗」如何共同作用的問題。

研究動機

本研究的核心動機是：在醫療評論平台中，匿名不是單純的缺點，反而可能在某些情境下成為可信度的保護機制；而文本結構也不是中性的載體，可能作為匿名性的補償性線索。這種互補關係使我們不應只問「評論者是否匿名」，而應問「匿名之下，哪些文本形式能夠被讀者當作診斷性證據」。

現有方法之所以不夠好，主要是因為它們把來源可信度與文本可信度分開看待，忽略了資訊處理中的整合判斷。使用者看到一則評論時，往往會先快速掃描身份線索建立初始預期，再透過文本中的具體敘述、事件連貫性、屬性數量與情緒節奏去修正判斷。這表示真正影響醫師選擇的，不是單一線索，而是線索之間是否一致、是否可被驗證、是否提供足夠的「敘事證據」。

本研究受兩個直覺啟發。第一，像偵探讀案卷一樣，使用者可能會把結構完整、時間順序清楚、細節可對照的評論視為更像親身經歷，而不是純粹抱怨或宣傳。第二，在匿名情境下，評論者若沒有可識別身分，反而可能讓負評更像「無利益衝突的揭露」，但前提是文本必須具備高診斷性；若文本空泛，匿名就只會增加不確定性。因此，我們提出一個更貼近真實平台治理的觀點：可信度不是匿名性的對立面，而是匿名性與文本證據共同建構的結果。

若此模型成立，平台即可從「只看身份」轉向「身份 × 文本」的多層標記，例如標示具備高經驗線索與高診斷性敘事的評論、對低診斷性情緒文實施折扣排序、或在負評內容旁加入結構完整度指標。這不僅能提升使用者做出更穩健的醫師選擇，也能為醫療資訊治理提供更細緻的規範依據。

提出方法

本研究提出一個「雙層線索可信度模型」(Two-layer Cue Credibility Model, TCCM)，主張匿名醫師評論的可信度判斷並非單層來源判斷，而是由「評論者資訊層」與「評論文本層」共同構成，兩層之間存在加乘、抵銷與情境依賴的交互作用。

第一層是評論者資訊層，包含頭像風格、ID 呈現、評論歷史、主題專長累積、是否持續針對醫療服務發表評論等。此層的功能不是直接證明真偽，而是提供「社會存在感」與「經驗可靠性」的初步判斷。第二層是評論文本層，包含長度、分段、具體性、可驗證屬性數量、敘事策略、情緒語調、因果鏈完整度與時間序列清晰度。此層的功能是提供「事件可想像性」與「經驗可檢核性」。我們假設：在匿名情境中，使用者會特別依賴第二層來補償第一層不足；而第一層若足夠強，則會提高使用者對第二層線索的容忍度與解讀偏誤。

方法上，本研究採三階段混合設計。第一階段是刺激材料建構：以真實平台風格為基礎，設計多組評論者頁面與評論文本，並用預試驗校正「身份線索強弱」「經驗線索高低」「正負評」「文本診斷性高低」四個維度。身份線索強時，頭像與 ID 會顯示穩定且中性的人設，如長期關注醫療議題、固定發文類型、視覺上專業但仍匿名；身份線索弱時，則使用隨機字串、模糊頭像或缺乏一致性的個人頁。經驗線索高時，頁面展示多則連續且主題聚焦的醫療評論，形成專長累積印象；經驗線索低時，則呈現稀少且分散的評論紀錄。文本診斷性高時，評論具有清楚的就診背景、症狀、等待流程、醫病互動、治療建議與結果、以及至少兩項可驗證屬性；診斷性低時，評論則較情緒化、抽象、跳躍或只有星等與簡短感受。

第二階段是情境式實驗。受試者將被隨機分派閱讀一系列醫師評論情境，並在每個情境後回報四類結果：認知信任（是否覺得評論者懂、穩定、可依據）、情感信任（是否覺得評論者友善、誠懇、值得同理）、評論可信度（是否覺得這則評論真實且可參考）、醫師選擇意向（是否願意依此評論選擇該醫師或將其列入候選）。此處的創新不在於單純測平均差異，而是檢驗「雙層一致性」：例如，當匿名性高但文本診斷性也高時，使用者是否會產生補償性信任；當身份線索強但文本空泛時，是否反而觸發懷疑；當負評且高診斷性時，是否比正評更能提升認知信任但不一定提升情感信任。

第三階段是機制建模與外部驗證。我們不只做傳統 ANOVA 或回歸，也會建構一個結構方程與多層次模型：將來源線索與文本線索視為前置變項，認知信任與情感信任作為雙中介，評論可信度作為近端結果，醫師選擇意向為遠端結果。同時加入情境調節，例如健康焦慮、醫療涉入、過往線上評論使用頻率、對匿名性的態度、以及是否具備醫療背景。為了更接近平台真實情境，我們還會建立一個「文本證據指標」：由人工編碼與語言模型共同估計文本中的具體性、可驗證性、屬性密度、時間鏈完整度與情緒穩定度，再與受試者主觀評分交叉比對，檢驗哪些語言特徵最能觸發可信度。

本研究的最大創意是提出「匿名不等於不可驗證」的設計觀。評論者資訊不再只是真實身分的替代品，而是與文本結構一起形成一種可推理的可信度框架。換言之，我們不是找出誰最像真實病人，而是找出什麼樣的匿名評論組合最像一則高品質、可採納的醫療證詞。若結果支持假設，平台未來可把評論排序從單純依星等與有用票數，轉向依「雙層可信分數」排序，並在介面上標示評論的結構完整度、經驗一致性與證據密度，讓使用者在資訊過載下更快辨識值得閱讀的評論。

實驗計畫

第一步，建立刺激材料庫。先蒐集真實醫師評論平台中的公開評論與使用者介面元素，整理出常見的匿名頭像、ID 型態、評論歷史呈現方式、星等與文本格式，再由研究團隊依四個操弄維度重寫成標準化刺激：身份線索強/弱、經驗線索高/低、正/負評、文本診斷性高/低。為避免內容混淆，所有刺激都維持相近主題，例如同一醫療科別或同一常見就診情境，確保差異主要來自操弄因素。

第二步，進行前測與操弄檢核。招募約 30 至 50 位與正式樣本特徵相近的受試者，檢驗各版本是否被正確感知為「匿名性高低不同」「經驗豐富程度不同」「正負評不同」「文本具體性不同」。操弄檢核題可包含：你認為這位評論者是否像經常評論醫療議題的人？這則評論是否具體到足以驗證？這則評論是否情緒化或敘事完整？若檢核不通過，需重新調整刺激文本。

第三步，正式招募樣本。建議以近期有使用線上評論經驗、且至少曾搜尋醫療或服務類評論的成年人為對象，目標樣本可設定 120 至 200 人，以利組內設計與交互作用檢驗。若資源足夠，可進一步加入台灣與國際樣本比較，以檢驗文化差異對匿名信任的影響。

第四步，實施情境式實驗。受試者依隨機順序閱讀多組評論頁面，每組頁面包含評論者資訊、評論內容與基本醫師情境。每看完一則，立即填答認知信任、情感信任、評論可信度與醫師選擇意向量表。量表可採 7 點李克特尺度，並加入注意力檢核題，避免隨機作答。若要更貼近真實平台，可採模擬瀏覽任務，要求受試者在多位醫師中選出最想預約者。

第五步，收集輔助資料。除主觀問卷外，可記錄閱讀時間、滑動停留、點擊評論者歷史紀錄的次數，以及是否回看文本中的特定細節，以作為行為性指標。若條件允許，可進一步使用眼動或鼠標追蹤，觀察受試者是否在高診斷性文本上停留更久，或在身份線索強時較快形成判斷。

第六步，建立分析模型。先以重複量數 ANOVA 或線性混合模型檢驗主效應與交互作用，再以結構方程模型驗證「身份線索與經驗線索 → 認知/情感信任 → 評論可信度 → 選擇意向」的中介路徑。另可加入多層次分析，將評論文本層次的語言特徵作為第二層變項。若有條件，也可使用可解釋的文本分析工具，例如句子分段數、屬性詞密度、時間詞序列、因果連接詞、情緒極性變化與具體名詞比例，形成一個「文本診斷性分數」。

第七步，設計 baseline 與成功指標。baseline 至少包括：只看星等排序、只看匿名/非匿名、有用票數排序、僅身份線索模型、僅文本特徵模型。成功的結果不只是某一條件平均分數較高，而是證明雙層模型優於單層模型，尤其在正負評、身份線索強弱與文本診斷性高低交互作用上具有顯著解釋力。若發現高診斷性文本能在匿名情境下顯著提升評論可信度，且這種提升可進一步轉化為醫師選擇意向，就代表本研究的核心假設成立。若再進一步發現負評在高診斷性條件下比正評更能提升認知信任，但不一定提升情感信任，則可支持「結構完整的負評作為警示證據」的理論推論。

第八步，進行外部驗證與設計轉譯。可把實驗所得規則轉成平台介面原型，測試不同排序或標記機制，例如「高證據密度優先」「高經驗一致性標籤」「匿名但高診斷性」提示，觀察使用者是否更有效率地選擇醫師。最終輸出不僅是理論模型，也是一套可落地的資訊治理建議，包括評論排序、可信標記與醫療評價平台的內容設計原則。

可信新穎度 — 最接近的真實論文

- How reviewers' profiles affect user's judgment of physicians (80.6% · airiti.AL, 2023) — 高度重疊：本研究不只比較評論者的身份線索與經驗線索，還進一步把「文本結構/診斷性」納入核心自變項，並檢驗身份線索與文本線索的交互作用，以及對認知信任、情感信任與醫師選擇意向的連鎖影響。相較之下，該文主要聚焦在匿名醫師評論情境中，不同類型的社會線索（身份與

經驗) 如何影響使用者對評論者的感知、信任與醫師選擇, 未將評論文本的結構化特徵作為主要操弄或分析重點。(相似度 81% 偏高, 標籤經相似度守衛下修)

- A Semi-Supervised Deep Learning Model for Fake Review Detection (62.8% · airtiti.AL, 2025) — 增量: (模型未提供差異說明; 以相似度為準)
- Enhancing the Credibility and Transparency of Academic Peer Review Using Blockchain and Reviewer Quality Control Mechanisms (59.5% · airtiti.AL, 2025) — 增量: (模型未提供差異說明; 以相似度為準)

參考文獻

1. How reviewers' profiles affect user's judgment of physicians
2. Investigating the Structural and Textual Characteristics of Internet Physicians Review
3. The Influences of Characteristics of Medical Institutions and Physicians on Physicians' Choice of Surgical Methods of Intracranial Aneurysms
4. Bringing Credibility through Portals: Content-aggregation on Web-based Health Information
5. Word-of-Mouth Effects on Hospital Choice and Moderator Variables
6. The Study of Relationships between College Student's Cognitions on Levels of Care and Choice Behaviors of Health Care Institutions
7. Attitudes toward Telemedicine and Willingness to Use in Taiwan: An Exploratory Analysis
8. Exploring Patients' Regular Source of Care Indicators in Taiwan
9. The Impact of Promotion Program on Physicians' Choice Behavior
10. Investigation on Health Care Choice and Utilization of Preventive Health Care Service of Young People: Healthcare Workers vs. Non-healthcare Workers
11. The Study of the Effects of Source Credibility of Word-of-Mouse, Consumers' Trust and Involvement on Purchase Intention
12. 網路口碑之訊息信任對遊客選擇民宿住宿意願影響之研究—以花蓮地區為例
13. The Effects of Electronic Word-of-Mouth and Product Information Quality on Brand Trust: The Application of the Elaboration Likelihood Model
14. Factors Influencing Patient's Choice of Hospital and Satisfaction with the Ambulatory Service of Seven Chinese Medicine Hospitals in Taichung
15. A Survey of New Hospital Patients on Their Selection of Medical Information Media and Care Providers
16. The Impact of Online Review and Price on Hotel Booking Intention at Online Travel Agency: Trust as a Mediating Variable
17. A Study of the Impact of Consumer Feedback Mechanism for Online Reviews: The Role of Online Review Helpfulness and Online Review Visibility

18. Evaluating the Helpfulness of Online Hotel Reviews
19. 基於情緒模式預測產品評論之幫助性
20. The impact of electronic word-of-mouth: The case of makeup and beauty care.
21. Factors Affecting Choice of Specialty in Different Level of Physicians
22. The Study of Consumer Behavior After Non-surgical, minimally invasive Cosmetic Treatments -A Study of Customers Receiving Cosmetic Treatments
23. Research on the Factors Influencing the Usefulness of Online Reviews–Mediating Effect based on Online Interaction
24. A study of negativity bias effect of usefulness of word of mouth based on sentiment analysis of actual online customer reviews
25. The Impact of Information Quality and Perceived Risk on the Adoption of Google Reviews
26. Longitudinal Analysis of Online Consumer Reviews
27. The Effect of Perceived Value of Online Travel Reviews on Tourists Purchase Attitudes
28. Internet Use Motivations, Perceived Credibility of Online Information, and Decision-Making
29. Risk Communication on the Annuity Reform Issue: Applying Situational Theory to the Public to Examine Public Risk Perceptions, Communication Behaviors, and Propensity to Support Policies
30. Whose online reviews to trust? Understanding reviewer trustworthiness and its impact on business
31. Impact of Anonymity on Consumers' Online Reviews
32. Toward a more robust theory and measure of social presence: Review and suggested criteria
33. Social Presence on LinkedIn: Perceived Credibility and Interpersonal Attractiveness Based on User Profile Picture
34. Online first impressions: Person perception in social media profiles
35. Profile Photos' Impact in Online Reviews: The Effect of Cultural Differences
36. Risk assessment in e-commerce: How sellers' photos, reputation scores, and the stake of a transaction influence buyers' purchase behavior and information processing
37. Examining the relationship between reviews and sales: the role of reviewer identity disclosure in electronic markers
38. How fakes make it through: the role of review features versus consumer characteristics
39. The effects of review valence in organic versus sponsored blog sites on perceived credibility, brand attitude, and behavioural intentions
40. An examination of negative e-WOM adoption: Brand commitment as a moderator

41. Eight Questions About Physician-Rating Websites: A Systematic Review
42. An Analysis of Online Evaluations on a Physician Rating Website: Evidence From a German Public Reporting Instrument
43. A Changing Landscape of Physician Quality Reporting: Analysis of Patients' Online Ratings of Their Physicians Over a 5-Year Period
44. What Do Patients of Different Medical Illness Say About Their Doctors Online? An Analysis of Online Physician Reviews

匿名醫師評論者的計算可信度剖析能否補償匿名偏誤並提升病患選醫決策？

後設資料

想法編號: seed-theory-3=>3=>1=>1

新穎度: 38.7%

最大相似度: 61.3% (近似於: “Estimating Reviewer Credibility Using Review Contents and Review Histories”)

群集: 7

競賽得分: 2 勝

方法論契合度: 2/5

問題陳述

線上醫師評價網站在病患資訊搜尋、醫師選擇與醫療消費決策中扮演愈來愈重要的角色，但其核心矛盾在於：為了保護病患隱私，平台通常要求或鼓勵匿名發文，卻也因此削弱了評論者身分可見性，讓使用者對評論者的可信度難以判斷。既有研究已指出，匿名性可能降低信任與採納意願；然而，匿名並不必然等於不可信。某些評論者即使不揭露真實身分，仍會在長期互動中展現穩定的語言風格、主題專注度、時間規律、跨醫師評價一致性與可驗證的經驗線索，這些都可能構成一種「可計算的可信度軌跡」。本研究要處理的問題是：在醫師評論場景中，能否從匿名評論者的語言與行為歷史中，建立可預測其可信度的計算模型，並進一步驗證這些模型所抓取的線索是否比一般使用者直覺更穩定、更可泛化。

此問題之所以重要，在於它同時連結資訊檢索、資訊行為、知識組織與健康資訊素養。對病患而言，誤信低可信度評論可能導致錯誤的醫師選擇；對平台而言，若僅依賴星等或按讚數，容易放大熱門偏誤與虛假評論；對研究者而言，現有評論有用性或可信度研究多聚焦「單則文字」而非「評論者歷程」，因此無法回答匿名情境下的信任是如何累積、如何被重建。更進一步，本研究也觸及醫療資訊倫理：如果演算法能夠在不揭露真實身分的前提下提供可信度提示，或許可兼顧隱私保護與資訊品質控制，為中文醫療評論平台提供一種兼具公平性與可操作性的設計方案。

現有方法

既有方法大致可分為三類。第一類是評論有用性、可信度或假評論偵測模型，常使用評論文字的情感詞、主題特徵、句法複雜度、長度、標點、極性強弱，以及評論者的歷史行為（發文頻率、平均評分、過往被標記次數）來做分類。這類方法在電商情境較成熟，但多以評論是否有用、是否真假為目標，未必能對應到醫師評論中的「可信度」與「選醫決策」。第二類是社會線索與信任研究，通常透過實驗操弄頭像、ID、匿名程度、評分效價、評論數量、經驗線索等，觀察使用者如何形成對評論者與評論內容的信任。這類研究能說明人類如何依賴線索，但多把評論者當成靜態刺激，較少建立可部署的預測模型。第三類是評論者聲譽或專家鑑別機制，例如投票、徽章、平台等級、同儕標記或區塊鏈式審查。這些機制雖能提升透明度，但容易受馬太效應、互惠偏誤與平台規則限制，也常要求明確身分或需要大量人工標註。

其限制在於：第一，很多模型只看文本，不看評論者行為歷史，因此無法辨識長期穩定的可信度模式；第二，多數研究以產品評論為主，醫療評論具有高風險、情緒與經驗混雜、且受隱私限制更強，不能直接套用；第三，現有實驗常只測使用者對單則評論的反應，缺乏把「演算法可信度分數」與「人類主觀信任」放在同一框架中比較；第四，匿名性常被視為單一負向因子，較少探討匿名是否可由足夠強的歷史軌跡與語言穩定性部分補償。

研究動機

本研究的動機是將「匿名」從單純的信任阻礙，重新定義為一種可被歷程訊號部分抵消的缺口。人類在判斷評論可信度時，常被表層線索左右，例如頭像、ID、星等或正負向語氣；但真正可信的評論者未必最會包裝自己，而可能是長期在特定醫療主題上保持一致、具體、有限誇飾、且回饋結果穩定的人。這種可信度不是單則評論能完整顯示，而是必須從「評論者生命史」中抽取。也就是說，可信度更像一個可累積的資訊組織現象：它存在於跨評論、跨醫師、跨時間的模式裡。

因此，本研究引入一個比傳統評論有用性預測更激進的想法：用「可信度軌跡」替代「單點內容判斷」。若模型能從語言風格與行為歷史中學到穩定且可解釋的信號，便可在匿名情境下提供一種非侵入式的補充標記，幫助使用者不再僅憑匿名外觀做判斷。另一方面，若實驗顯示受試者其實會依賴與模型相似的線索，則代表這些信號具有心理真實性；若不一致，則更能揭示人類與演算法在可信度形成上的落差，為資訊素養教育與平台介面設計提供具體方向。這種雙軌設計之所以可能比既有基線更有效，是因為它同時利用了靜態語言證據與動態行為證據，並用受控實驗驗證其可感知性與可接受性，而不是只停留在分類指標。

提出方法

本研究提出一個名為「評論者可信度軌跡框架」(Reviewer Credibility Trajectory Framework, RCTF) 的混合式方法。整體上，它由三個互相咬合的模組構成：第一，建置醫師評論者層級語料庫，將每位匿名評論者視為一個可追蹤的資訊主體；第二，從語言與行為中萃取「可信度特徵群」，訓練可解釋的多模態可信度模型；第三，將模型輸出的可信度分數轉換為實驗刺激中的「數位社會線索」，觀察其是否能補償匿名偏誤並影響選醫決策。

在語料庫建置上，不只蒐集單則評論，而是蒐集每位評論者在醫師評論網站上跨時間、跨醫師的發文串。每位評論者形成一個「歷史檔案」，包括評論文字、評分、日期、主題標籤、互動回饋（如有用票、留言、被回應次數）、以及評論者個人檔案中可見的弱線索（例如 ID 形式、是否有自我介紹、是否長期使用相同稱謂）。接著以評論者為單位建立特徵表，而非以評論為單位。語言特徵方面，除常見的可讀性、情感極性與主客觀度外，本研究特別重視「認知節制」與「論證具體性」：例如確定性詞彙密度、模糊語標記、因果連接詞、醫療細節與情境詞、可感知具體詞比例、第一人稱自我介入程度、以及正負評是否呈現平衡而非極端化。行為特徵方面，則包括主題一致性、時間規律性、評論量分布、跨醫師多樣性、重複用語模式、以及是否在不同醫師評論中保有相似的論證結構。

模型設計上，我們不採單一黑箱分類器，而是建立「層級式可信度圖譜」。第一層使用文字編碼器將每則評論轉為向量；第二層以序列模型或時間感知 Transformer 彙整同一評論者的歷史評論，捕捉其長期風格穩定性與主題漂移；第三層加入可解釋的特徵門控機制，分別輸出「語言可信度」、「行為可信度」與「整體可信度」三個分數。標註目標不只是一個單一標籤，而是多重弱監督訊號的組合：例如評論是否被後續使用者判定為有用、評論是否與其他高可信評論者在相同醫師主題上高度一致、評論內容是否被外部可驗證資訊支持、以及少量專家（醫療資訊與圖書資訊學背景）對評論可信度的盲評。模型訓練採多任務學習與排序學習並行，使其同時學會分類高/低可信度與排序評論者可信度。

為了避免模型只學到「話多就是可信」或「負評就是不可信」這類偏誤，我們會加入反事實對照與對抗約束：例如將同一評論者的文本抽換成不同可讀性版本，或保持內容不變而打亂評論歷史順序，檢驗模型是否真正依賴可信線索而非表面長度；同時使用對抗訓練降低對匿名 ID 格式、極端情緒字的過度依賴。最終產出的不是單純分數，而是一組可視化的可信度剖面圖，告訴系統與研究者：這位評論者的可信度主要來自於穩定的主題聚焦、具體的醫療敘述，還是長期規律的發文歷史。

實驗端則把模型分數轉譯為可操弄的社會線索。受試者不只看到匿名評論者的 ID 與頭像，還會看到一個「系統生成的可信度標記」，其呈現方式可以是中性語言，例如「此評論者過去在相似醫療主題上保持高一致性」或「此評論者的歷史發文顯示較高的情境穩定度」。我們將操弄三個因素：匿名程度（完全匿名、弱匿名、具歷史軌跡但無真實身分）、歷史強度（無歷史、低一致性歷史、高一致性歷史）、語言風格（高具體高論證、模糊高情緒、混合型）。參與者在閱讀評論後需評估評論者可信度、評論可信度、選醫意圖與風險感知。此設計可直接比較：人類是否更相信與模型高分一致的刺激？匿名是否

在有強歷史線索時不再是劣勢？若答案為是，則代表演算法可信度提示具有補償功能；若模型高分但人類不信，則可揭示設計與介面呈現方式的問題。

本方法之所以具有創新性，在於它把「可信度」從單篇內容判斷升級為可計算、可解釋、可實驗驗證的歷程概念，並以此連結資訊檢索中的排名、資訊行為中的信任形成、與知識組織中的證據整合。這不只是做一個預測器，而是在建立一套可部署於醫療評論平台的可信度基礎設施。

實驗計畫

第一步是資料蒐集與語料建庫。選擇台灣具代表性的醫師評論平台或具公開評論機制的醫療評價網站，蒐集至少三到五年期間的評論資料，目標是形成數千名評論者、數萬則評論的評論者層級資料集。若平台資料取得受限，可搭配網頁爬蟲與人工抽樣標註。每筆資料需包含評論者匿名 ID、評論時間、醫師類別、評分、正文、互動回饋與可見個人檔案資訊。接著建立評論者歷史串，按時間排序。為了利於跨語言與跨平台推廣，可選取繁體中文資料為主，並保留少量英文或雙語評論作外部驗證。

第二步是標註與黃金標準建立。採多層標註：其一，使用評論有用性或下游互動回饋作為弱標籤；其二，邀請醫療資訊、圖資與語言學領域專家對抽樣評論者進行盲評，判定其可信度高低；其三，設計一致性標註，讓同一評論者在相近主題下的前後評論由人工判斷是否保持敘述穩定。這些標籤不要求完全一致，而是用於多任務學習與魯棒性測試。

第三步是模型訓練與基線比較。基線至少包括：只用文本內容的 Logistic Regression / SVM、只用行為特徵的 XGBoost、評論有用性預測模型、假評論偵測模型、以及不含時間資訊的 Transformer。提案模型則為層級式多任務模型。評估指標包含 AUC、F1、Macro-F1、MRR、NDCG，以及評論者層級的一致性指標（如 Spearman 相關、校準誤差 ECE）。另外加入可解釋性評估，例如特徵重要度穩定性、反事實測試成功率，以及專家對模型解釋的可接受度。

第四步是受控實驗設計。採組內或混合設計，至少納入 $2 \times 3 \times 3$ 的操弄：匿名程度（完全匿名、弱匿名、歷史化匿名）、歷史強度（無、低、高）、語言風格（模糊情緒、平衡論證、具體論證）。每位受試者閱讀多個醫師評論情境，隨機分派順序以消除順序效應。依變項包括對評論者可信度、評論可信度、醫師選擇意圖、風險感知與資訊採納意願。為比較人類與模型，可在部分條件中顯示系統可信度標記，在部分條件中隱藏，檢驗標記是否改變判斷。

第五步是分析與成功判準。若模型在評論者可信度分類上顯著優於只看文本或只看行為的基線，且在校準與可解釋性上表現良好，代表可信度軌跡框架有效。若實驗顯示：在有強歷史軌跡時，匿名帶來的信任劣勢顯著下降；或系統可信度標記可顯著提高低匿名線索條件下的採納意圖，則可說明計算可信度訊號能補償匿名偏誤。反之，若人類仍過度依賴表層匿名線索而忽略歷史與語言證據，也同樣具有重要貢獻，代表平台需要更明確的介面設計與資訊素養介入。

最後，可加做外部驗證：使用另一個醫療問答或健康論壇資料集測試模型遷移性，或以小型線上原型介面測試「可信度標記」對真實選醫任務的影響。若模型與人類判斷的一致性提升，且能降低匿名偏誤、提高選醫判斷品質與校準度，即可視為本研究成功。

可信新穎度 — 最接近的真實論文

- Estimating Reviewer Credibility Using Review Contents and Review Histories (61.3% · airtiti.AL, 2012) — 增量: 本文主要以「評論內容與評論歷史」來估計一般商品/網站評論者的可信度，重點在找出哪些評論者提供有價值資訊；本提案則是鎖定「醫師評論場景」中的匿名評論者，建立評論者層級的長期歷程模型，並把可信度分解為語言、行為與時間軌跡三個面向，再進一步測試其是否能作為選醫決策的社會線索。也就是說，提案不只做可信度偵測，而是把可信度模型接到匿名偏誤補償與病患決策影響的實驗驗證。
- Exploring Credibility in Online Product Reviews: Does Language Style Matter? (58.8% · airtiti.AL, 2015) — 增量: 這篇文獻談的是產品評論中「語言風格是否影響可信度知覺」，核心角度是單則評論的語言表現與讀者判斷之關聯；本提案則不只看語言風格，還要蒐集評論者跨時間、

跨醫師的歷史行為，建立可計算的可信度軌跡模型。換言之，本提案加入了評論者層級歷程、行為特徵、可解釋多模態建模與選醫決策實驗，研究問題與方法都比這篇更大也更具體。

- How reviewers' profiles affect user's judgment of physicians (58.4% · airtiti.AL, 2023) — 高度重疊: 這篇研究是用社會訊息處理理論與社會臨場感理論，透過實驗操縱評論者的身份與經驗線索，觀察這些可見社會線索如何影響使用者對醫師的信任與選擇；本提案則相反，是要在匿名前提下從評論者的語言與行為歷史中推估其可信度，並檢驗演算法產生的可信度提示能否補償匿名偏誤。也就是說，該文著重「哪些外顯線索會影響人」，本提案著重「能否從匿名資料本身計算出可信度，並把它轉成可用的決策支援」。

參考文獻

1. How reviewers' profiles affect user's judgment of physicians
2. The Relationship among Trust, Satisfaction and Loyalty in Professional Medical Services: The Case of Taiwan
3. Exploring the mediating roles of heart failure patients' obedience and security-seeking in the relationships between patients' trust in cardiologists and their physical and psychological outcomes
4. A Computational Linguistic Approach to Characterize Reputable Reviewers in Online forums
5. A Semi-Supervised Deep Learning Model for Fake Review Detection
6. How Reliable Information Matter? Co-creating Value with Consumers Using Unboxing Reviews and Locating Reputable Reviewers by Linguistics Styles
7. The Relationship of UX and Perceptions of Credibility
8. Exploring image in language concreteness reviews and two-sided reviews on online review helpfulness
9. Aspect-Based Review Helpfulness Prediction
10. The Study of Online Comments Helpful for Vehicle Purchase Decision among Military Personnel
11. A Study of Identifying Factors of Influencing Trust in O2O Models: An Example of OpenTable
12. Estimating Reviewer Credibility Using Review Contents and Review Histories
13. Enhancing the Credibility and Transparency of Academic Peer Review Using Blockchain and Reviewer Quality Control Mechanisms
14. A Study on the Persuasive Effect of Online Commenters and Arguments
15. 基於情緒模式預測產品評論之幫助性
16. Exploring Credibility in Online Product Reviews: Does Language Style Matter?
17. The Influences of Product Review Credibility and Product Rating Credibility on Browsers' Product Attitudes: An Online Platform of Cosmetics

18. Are negative reviews more credible and useful? The moderating effects of negative emotions and product types
19. The Impact of Online Review Related Credibility on Behavioral Intentions on Online Platform
20. The Influence of Perceived Importance and Credibility regarding Health Information in Media on Health Information-Seeking Behavior
21. Accreditation of Website Credibility: Concept, Discourse, and Operational Framework
22. Investigation of the Live Stream E-commerce from Affordance Theory
23. The trust mechanism of platform of sharing economy: A case of Uber
24. A Study on College Students' Trust in the Distance Learning System based on the Trust Building Model
25. 新媒體時代的健康傳播：以「健康力智慧健康服務平台」為例
26. THE CAUSES AND EFFECTS OF USERS ONLINE ANONYMITY CONCERN
27. Whose online reviews to trust? Understanding reviewer trustworthiness and its impact on business
28. Impact of Anonymity on Consumers' Online Reviews
29. Toward a more robust theory and measure of social presence: Review and suggested criteria
30. Social Presence on LinkedIn: Perceived Credibility and Interpersonal Attractiveness Based on User Profile Picture
31. Online first impressions: Person perception in social media profiles
32. Profile Photos' Impact in Online Reviews: The Effect of Cultural Differences
33. Risk assessment in e-commerce: How sellers' photos, reputation scores, and the stake of a transaction influence buyers' purchase behavior and information processing
34. Examining the relationship between reviews and sales: the role of reviewer identity disclosure in electronic markers
35. How fakes make it through: the role of review features versus consumer characteristics
36. The effects of review valence in organic versus sponsored blog sites on perceived credibility, brand attitude, and behavioural intentions
37. An examination of negative e-WOM adoption: Brand commitment as a moderator
38. Eight Questions About Physician-Rating Websites: A Systematic Review
39. An Analysis of Online Evaluations on a Physician Rating Website: Evidence From a German Public Reporting Instrument
40. A Changing Landscape of Physician Quality Reporting: Analysis of Patients' Online Ratings of Their Physicians Over a 5-Year Period
41. What Do Patients of Different Medical Illness Say About Their Doctors Online? An Analysis of Online Physician Reviews

匿名醫師評論中，內容證據與影像佐證如何補償身份缺失並塑造可信醫療見證者？

後設資料

想法編號: seed-theory-3=>2=>1=>2

新穎度: 38.0%

最大相似度: 62.0% (近似於: “Estimating Reviewer Credibility Using Review Contents and Review Histories”)

群集: 8

競賽得分: 2 勝

方法論契合度: 3/5

問題陳述

線上醫師評論平台在台灣與國際上已成為病患選擇醫師的重要資訊來源，但這類平台長期面臨一個根本張力：為了保護病患隱私，評論者通常採匿名或弱身份揭露設計；然而，匿名也會削弱讀者對評論者經驗真實性、動機純度與判斷能力的信任。既有研究多聚焦於評論者的頭像、ID、評論歷史或身份線索是否足以提升信任，較少深入探討：在醫療評論這種高風險、高情緒、高資訊不對稱的情境中，讀者是否會改以評論內容本身來重建信任，並將評論者想像成不同的溝通角色，例如謹慎見證者、積極倡議者、挑別懷疑者、或有證據支撐的病患。

本研究要處理的問題是：當評論者身份不可見或不完整時，哪些內容特徵最能補償身份缺失，並使讀者將評論視為可信且可用的醫療決策依據？具體而言，評論的具體性、雙面性（同時包含優缺點）、以及是否附帶影像證據，是否會影響讀者對評論者可信度、情感信任、認知信任、評論有用性與就醫意圖的判斷？更進一步，影像並不只是額外資訊，而可能改變讀者對負評的道德歸因：同樣是負面醫師評論，若有病歷截圖、排隊紀錄、藥袋、院內照片或時間軸佐證，讀者可能將其解讀為合法警訊；若缺乏影像，則可能被視為情緒化攻擊或報復性評論。

此問題之所以重要，在於它同時涉及資訊可信度、數位健康決策、平台治理與病患權益。若平台無法辨識何種內容證據最能支持可信醫療評論，就可能導致高品質評論被埋沒、低品質評論被放大，進而影響病患就醫選擇、醫病關係與醫療市場公平性。本研究因此不只是檢驗評論特徵效果，而是要建立一個可遷移的理論框架，說明「內容證據如何在匿名環境中替代身份線索，並觸發特定的見證者原型推斷」。

現有方法

現有研究大致可分為三類。第一類是線上評論的外部線索研究，常檢驗評論者頭像、ID、評論歷史、專業標籤、認證徽章、評分數量與極性等如何影響可信度與採納意圖。其限制在於：過度依賴身份訊號，卻較少討論當身份弱化時，內容本身如何成為主要的可信度來源。第二類是評論內容品質研究，常以具體性、資訊豐富度、情緒強度、雙面性、一致性與可讀性預測有用性。其限制在於：這些研究多以電商或旅遊評論為主，未充分考慮醫療場域的風險、倫理與證據性要求。第三類是多媒體評論研究，常探討圖片張數、圖片品質或圖文一致性對有用性與購買意圖的影響。其限制在於：圖片通常被當作增加生動性或說服力的附加元素，而不是被視為能改變「評論是否合法、是否值得相信」的證據型訊號。

在醫師評論情境下，既有基準方法多以單一線索主效應為主，例如比較匿名與具名、正評與負評、是否有評論歷史、是否有頭像等。即使有少數研究開始關注雙面評論或具體性，也多未與影像證據、匿名程度和身份豐富度做交互設計，更缺乏對讀者認知歸因的中介機制分析。換言之，現有方法往往回答「哪種評論較有用」，卻無法回答「讀者把評論者看成誰、為何這種角色想像會讓內容更可信、以及影像

如何改變負評的道德判斷」。因此，這些方法不足以處理匿名醫療評論中最關鍵的問題：內容證據與視覺佐證如何共同補償身份缺失。

研究動機

本研究的動機來自三個現象。第一，匿名不是單純的缺點；在醫療場域中，匿名具有保護隱私與鼓勵揭露負面經驗的功能，因此真正的問題不是取消匿名，而是如何讓匿名評論仍能維持可信度。第二，讀者在面對匿名評論時，並不只是計算訊號數量，而是會主動推斷評論者的溝通角色：有些人像是理性記錄的見證者，有些像是為病患發聲的倡議者，有些像是嚴格挑錯的懷疑者。這意味著評論研究可從「評論者屬性」轉向「讀者對評論者的想像」。第三，影像在醫療評論中具有特殊性，它不只是增加生動感，還可能扮演證據、目擊、紀錄與合法性的象徵，尤其在負評情境下，影像可能將原本模糊的抱怨轉化為可驗證的警訊。

因此，既有方法之所以不夠，是因為它們把身份線索與內容線索分開處理，並預設身份越多越好。但在醫療評論中，最有趣的情況可能恰好相反：當身份幾乎不可見時，高具體性、雙面性與影像佐證的組合，反而可能成為最強的可信度補償機制。這也提供一個理論上更強的主張：評論可信度不是身份的直接函數，而是由『可歸責性、可驗證性與見證角色』共同建構。基於這個動機，本研究設計一個結合內容分析與情境實驗的混合式研究，讓內容訊號不只是自變項，而是能夠觸發特定認知原型的線索集合。我們預期這種方法比傳統單一線索模型更能解釋匿名醫療評論中的信任形成，且可直接轉化為平台設計建議，例如何種評論模板、影像提示與匿名層級最能提升高品質醫療資訊的可用性。

提出方法

本研究提出一個名為「證詞式評論訊號框架」(Testimonial Content Signature Framework, TCSF) 的新方法，核心概念是：在匿名醫療評論中，讀者並非只評估『這篇評論寫得好不好』，而是會根據內容組合推斷『這位評論者像哪一類可信見證者』。TCSF 將評論視為一種由四種訊號構成的證詞：1) 內容具體性，2) 雙面性，3) 影像證據，4) 身份豐富度。這四者不只是獨立變項，而是共同形塑讀者對評論者原型的歸因，進而影響評論的感知可信度、情感信任、認知信任、情緒判斷與醫師選擇意圖。

第一步，建構四種核心訊號的操作化。內容具體性指評論是否包含具體情境、時間、流程、醫療行為、感受與後續結果，例如「看診等了兩小時」比「很慢」更具體；雙面性指評論是否同時陳述優點與缺點，例如「醫師很細心，但候診很久」；影像證據指是否附帶能被解讀為佐證的圖片，例如掛號單、候診螢幕、藥袋、環境照片或去識別化的醫療紀錄截圖；身份豐富度則區分匿名、半匿名（有頭像與 ID 但無真實姓名）、與相對豐富檔案（有穩定頭像、評論歷史、專長標籤或社群足跡）。

第二步，提出「證詞補償機制」。本研究假設，當身份豐富度低時，內容證據的重要性上升；當內容證據足夠強時，讀者會把匿名評論者重新編碼為『可依賴的見證者』，而不是『不明動機的抱怨者』。這種補償不是線性加總，而是類似門檻效應：單獨的具體性或圖片可能有限，但當雙面性、具體性與影像共同出現時，匿名性帶來的不信任會被部分抵消。特別是對負評而言，雙面且具體的敘述加上影像，可能將負面訊息轉譯為「有根據的風險提醒」，因此比單純高分正評更能建立高層次的認知信任。

第三步，設計「評論者原型推斷」作為中介機制。傳統研究只測量對評論者的整體信任，本研究則加入四種讀者歸因角色量表：謹慎見證者 (careful witness)、倡議者 (advocate)、懷疑者 (skeptic)、證據型病患 (evidence-backed patient)。這些原型不是評論者真實人格，而是讀者從內容中推斷出的溝通角色。例如，高具體性與雙面性搭配影像，較可能誘發謹慎見證者；情緒強烈、缺乏證據的負評，較可能被歸為懷疑者或抱怨者；明顯為他人權益發聲、兼具具體問題描述的評論，則可能被看作倡議者；若有清楚時序與佐證，則會形成證據型病患的形象。這一層設計能把評論研究從『訊號強弱』推進到『訊號如何塑造可理解的社會角色』。

第四步，建立一個混合式研究流程。先進行內容預研究，蒐集台灣醫師評論平台上的真實評論語料，並請標註者評分具體性、雙面性、影像證據類型、可疑性與感知角色原型，以確認操弄材料的自然度。接著進行情境式 conjoint 實驗，將評論拆成多個屬性配置，讓受試者在多個假想醫師評論卡片中做選

擇與評分，從而估計各屬性的平均邊際貢獻。conjoint 的優勢在於可以模擬真實平台的多線索決策，而不是只看單一因素。

第五步，加入一個創新的視覺歸因操弄。影像不只分為有或無，還可分為『支持型影像』與『模糊型影像』：支持型影像直接對應評論內容，例如藥袋與副作用描述一致；模糊型影像雖然存在，但與評論主題關聯不明。這可檢驗一個重要理論問題：圖片提升可信度的前提不是存在，而是可解釋性與內容一致性。也就是說，影像不一定讓人更相信所有評論，但可能改變負評的解讀框架。

第六步，建立結果模型。主要因變項包括評論可信度、評論有用性、情感信任、認知信任、對評論者角色原型的歸因，以及選擇該醫師的意圖；次要因變項包括對負評道德性的判斷、風險感知與資訊過載感。分析上可使用多層次 conjoint 模型或混合效應迴歸，估計各屬性主效應與交互作用，並檢驗『影像 × 雙面性 × 具體性 × 匿名度』的補償關係。若要更具創新性，也可再加入文本分析：用生成式模型協助建立評論的語義原型，再與人工評分比較，以驗證讀者是否真的在意『證詞結構』而不只是表面情緒。整體而言，TCSF 的最大特點是把匿名醫療評論視為可解碼的見證系統，而非單純的文字好壞評估。

實驗計畫

第一步是語料蒐集與材料建構。從台灣常見醫師評論平台、社群討論與匿名醫療回饋文本中蒐集公開可見評論，涵蓋正評、負評與中性評論，並去識別化處理。建立一個初步語料庫後，請 3 到 5 位具資訊行為、數位健康或內容分析背景的標註者，對每則評論評分：具體性、雙面性、影像可解釋性、情緒強度、可疑性與原型歸因傾向。此階段的目標是找出最自然、最具代表性的評論句式與圖文組合，形成後續實驗刺激。可用 Krippendorff's alpha 檢驗一致性。

第二步是刺激材料設計。根據 conjoint 架構，設定四個屬性，每個屬性至少兩到三個層級：內容具體性（低/高）、雙面性（單面/雙面）、影像證據（無/模糊型/支持型）、身份豐富度（匿名/半匿名/豐富檔案）。每個受試者將看到多個醫師評論卡片，每張卡片包含同一位虛構醫師的不同評論組合，以避免醫師本身品質干擾。建議使用 12 到 16 組 conjoint 任務，每位受試者每組選 1 到 2 則最值得信任或最可能影響選醫決策的評論。

第三步是前測與操弄檢驗。先招募 30 到 50 位近期使用過線上醫療評論或健康資訊搜尋的受試者，檢查各屬性是否被正確感知，例如高具體性是否真的被視為更具體、支持型圖片是否被視為更有證據、雙面評論是否被視為更平衡。若操弄未達預期，調整文字與圖片類型。

第四步是正式實驗。招募至少 240 位台灣受試者，並可視資源擴充至 300 至 400 位，以支撐更穩定的交互作用估計。受試者條件建議為：過去一年內曾使用線上評論搜尋醫療或健康服務者。實驗流程包括：閱讀情境說明、完成基本人口學與醫療資訊使用習慣問卷、進入 conjoint 任務、每輪評估評論可信度、有用性、情感信任、認知信任、原型歸因、是否願意選擇該醫師，以及對負評是否屬於合理警訊的判斷。建議使用 7 點李克特量表。

第五步是比較基準模型。基線方法包括：只用平均評分模型、只考慮身份線索的模型、只考慮內容品質的模型、以及傳統評論有用性預測模型。進階基線可加入文本特徵模型，例如用 BERT 類模型抽取評論向量，再預測可信度；也可加入圖片存在與否的簡單二元模型。若 TCSF 的理論成立，則完整模型應在解釋力、預測力與對負評合法性判斷上顯著優於這些基線。

第六步是評估指標與成功標準。主要指標包括：評論可信度、情感信任、認知信任、評論有用性、醫師選擇意圖、負評合法性判斷與角色原型分數。統計上關注四類結果：1) 具體性、雙面性與支持型圖片的主效應是否正向；2) 內容證據是否在匿名條件下具有更強效果；3) 支持型圖片是否特別提升負評的合法性判斷；4) 評論者原型歸因是否中介內容特徵與信任/選擇意圖之間的關係。若匿名條件下，高具體性 + 雙面性 + 支持型圖片的組合能顯著提高可信度，且透過『謹慎見證者』與『證據型病患』原型中介，就可視為成功。

第七步是補充質性分析。從實驗後開放題收集受試者對「為何這則評論可信/不可信」的說明，進行主題分析，檢視是否出現『看起來像真的有去看診』『有照片所以不像亂講』『太情緒化像在發洩』等歸因語彙。這一步能驗證定量結果背後的認知機制，也能為台灣與國際論文提供更具說服力的理論敘事。

成功的結果應該長得像這樣：匿名不是致命弱點，只是需要被內容證據補償；圖片不只提升有用性，還會重新定義負評是警訊還是攻擊；而最強的評論不是最吵的，而是最像一位有證據、會自我修正、能

平衡利弊的可信見證者。

可信新穎度 — 最接近的真實論文

- Estimating Reviewer Credibility Using Review Contents and Review Histories (62.0% · airtiti.AL, 2012) — 增量: 這篇論文主要是從評論內容與評論歷史來估計『評論者可信度』, 重點在找出哪些既有評論者值得信賴; 你的提案則是把醫療評論中的內容具體性、雙面性、影像佐證與身份豐富度組合成一套『證詞訊號』, 進一步推論讀者如何把匿名評論者想像成不同的可信見證者原型, 並測量對醫師選擇意圖的影響。也就是說, 本文偏向以歷史/內容特徵預測評論者可信度, 你則是研究匿名情境下內容證據如何補償身份缺失並改變受眾的信任歸因機制。
- How reviewers' profiles affect user's judgment of physicians (56.9% · airtiti.AL, 2023) — 增量: 這篇研究聚焦於醫師評論網站中, 評論者的個人檔案與身份/經驗線索如何影響使用者對醫師的判斷, 核心是『評論者 profile 線索』與『醫師評價』之間的關係。你的提案則不把重點放在 profile 線索本身, 而是探討在匿名或弱身份揭露下, 評論內容與影像證據是否能補償身份缺失, 並透過評論者原型推斷來影響可信度、情感/認知信任與就醫意圖。
- Exploring Credibility in Online Product Reviews: Does Language Style Matter? (55.4% · airtiti.AL, 2015) — 區隔明確: 這篇文章研究的是產品評論中的語言風格是否影響可信度, 屬於一般性商品評論與文字表達層面的可信性判斷。你的提案則明確鎖定醫療評論情境, 且不只看語言風格, 而是把具體性、雙面性、影像佐證與身份豐富度放在同一個框架中, 分析匿名醫療見證如何被建構為可信證詞。

參考文獻

1. How reviewers' profiles affect user's judgment of physicians
2. Study on the Related Factors on Medical Loyalty of Outpatients
3. THE IMPACT OF PATIENT-PHYSICIAN RELATIONSHIP MANAGEMENT ON REVISITING INTENTION - TAKE TEACHING HOSPITAL FOR EXAMPLE
4. Exploring image in language concreteness reviews and two-sided reviews on online review helpfulness
5. A study on the effects of celebrity endorsement on one-sided and two-sided advertisement appeals
6. Factors Influencing Consumer Intentions to Use Online Photofinishing: A Perspective of Extended Technology Acceptance Model
7. The Relationship of UX and Perceptions of Credibility
8. Trust Prediction in Opinion Sharing Communities: A Learning-Based Classification Approach
9. The Impact of Online Review and Price on Hotel Booking Intention at Online Travel Agency: Trust as a Mediating Variable
10. The Relationship among Trust, Satisfaction and Loyalty in Professional Medical Services: The Case of Taiwan
11. A Study for Construct of Extrinsic Cue on Product Evaluation and Effect Measures Model

12. An Investigation of Online Review Sidedness Effect
13. The Impact of Language Arousal and Consumer Values on the Effectiveness of Online Reviews
14. Estimating Reviewer Credibility Using Review Contents and Review Histories
15. The analysis of differences between online book reviews and those in newspapers
16. Crowd sourcing and e-Commerce: Chinese Online Reviews
17. Exploring the Effect of Fake News Characteristic Markings on the Perceived Credibility of Readers with Different Cognitive Style in Fake News
18. The Moderation Effects of Happy and Anger on the Process of Evaluating Persuasive Arguments.
19. 新媒體時代的健康傳播：以「健康力智慧健康服務平台」為例
20. Are negative reviews more credible and useful? The moderating effects of negative emotions and product types
21. A Study on the Persuasive Effect of Online Commenters and Arguments
22. The Impact of Online Review Related Credibility on Behavioral Intentions on Online Platform
23. THE CAUSES AND EFFECTS OF USERS ONLINE ANONYMITY CONCERN
24. Whose online reviews to trust? Understanding reviewer trustworthiness and its impact on business
25. Impact of Anonymity on Consumers' Online Reviews
26. Toward a more robust theory and measure of social presence: Review and suggested criteria
27. Social Presence on LinkedIn: Perceived Credibility and Interpersonal Attractiveness Based on User Profile Picture
28. Online first impressions: Person perception in social media profiles
29. Profile Photos' Impact in Online Reviews: The Effect of Cultural Differences
30. Risk assessment in e-commerce: How sellers' photos, reputation scores, and the stake of a transaction influence buyers' purchase behavior and information processing
31. Examining the relationship between reviews and sales: the role of reviewer identity disclosure in electronic markers
32. How fakes make it through: the role of review features versus consumer characteristics
33. The effects of review valence in organic versus sponsored blog sites on perceived credibility, brand attitude, and behavioural intentions
34. An examination of negative e-WOM adoption: Brand commitment as a moderator
35. Eight Questions About Physician-Rating Websites: A Systematic Review

36. An Analysis of Online Evaluations on a Physician Rating Website: Evidence From a German Public Reporting Instrument
37. A Changing Landscape of Physician Quality Reporting: Analysis of Patients' Online Ratings of Their Physicians Over a 5-Year Period
38. What Do Patients of Different Medical Illness Say About Their Doctors Online? An Analysis of Online Physician Reviews

隱私保護驗證如何重塑匿名醫師評論的信任與選擇？

後設資料

想法編號: seed-theory-3=>2=>2=>3

新穎度: 38.9%

最大相似度: 61.1% (近似於: “How reviewers’ profiles affect user’s judgment of physicians”)

群集: 9

競賽得分: 1 勝

方法論契合度: 2/5

問題陳述

線上醫師評論已成為病患蒐集醫療資訊、降低不確定性與形成就醫選擇的重要來源，但醫療情境與一般消費情境不同：評論者往往同時承受隱私風險、社會污名風險與醫病關係風險，因此多數平台傾向採取匿名機制。然而，匿名雖然提升發聲意願，卻也削弱了評論者的可信度、責任感與平台公信力，造成「能保護隱私，卻難以建立信任」的結構性矛盾。既有研究已指出，評論者的身份線索、經驗線索與評論效價會影響使用者對評論者的認知信任、情感信任與醫師選擇意圖，但目前的做法多停留在「匿名 vs. 非匿名」或「有頭像 / 有歷史紀錄」等表層線索，尚未真正解決醫療場景中更核心的問題：如何在不揭露病患身分的前提下，讓平台能證明評論確實來自具備就醫經驗的真實患者，並降低灌水、抹黑、商業操控與自我審查的風險。

本研究要處理的問題是：不同的隱私保護驗證架構，是否能在維持匿名與安全的同時，提高使用者對醫師評論的信任、對平台的正當性感知，以及最終的醫師選擇意圖？更進一步，本研究關注的是一個更微妙但更重要的張力：當「評論者真實性」被提升後，使用者是否會覺得更安全、更可信，但也同時擔心個資追蹤、病歷外洩或被機構報復？這些感知可能在不同文化與制度環境下有巨大差異，尤其在台灣這種高度重視醫療秩序、同時又對個資外洩十分敏感的環境中，問題更具實務與政策意義。

因此，本研究不只是討論評論系統的介面設計，而是試圖建立一個可操作的社會技術框架，說明：哪些驗證訊號可以在不暴露病患身分的前提下增強信任？哪些機制會因過度透明而反而降低發聲意願？平台如何在病患隱私、反詐欺、醫療決策支援與公共討論之間取得平衡？這個議題對醫療資訊平台治理、數位健康資訊素養、評論可信度、以及醫療搜尋行為都非常重要，也具有跨國可比較性與高學術貢獻潛力。

現有方法

現有方法大致可分為四類。第一類是完全匿名的醫師評論平台，僅允許使用者留下評分與文字內容，不提供可追溯的身份驗證。其優點是保護隱私、降低參與門檻，但缺點是極易受到虛假評論、競爭對手攻擊、情緒性發洩與低品質內容影響，使用者只能依賴內容本身或粗略的評論數量做判斷。第二類是帶有弱身份線索的匿名系統，例如顯示頭像、暱稱、評論歷史、累積星等、主題專長標籤或「已驗證就診」標記。這類方法能部分提升可信度，但通常只能驗證「這個帳號看起來像真的」，無法證明其確實是該科別、該醫院或該次就診的病患。

第三類是平台後台審核與人工稽核，例如由平台編輯、客服或醫療機構審查評論內容，再決定是否上架。這種方法能降低明顯灌水，但成本高、可擴充性差，且容易引發審查偏誤、商業關係干擾或言論審查爭議。第四類是較新的可信機制，包括病患身分驗證、電子病歷串接、一次性驗證碼、第三方醫療憑證、區塊鏈存證、零知識證明、或可撤回的匿名憑證。雖然這些技術很有潛力，但多數研究停留在概念或系統原型，較少直接測量它們對使用者信任、感知安全與決策行為的心理效果，也很少比較不同驗證架構在「隱私保護—責任追蹤」光譜上的差異。

另外，既有研究通常把信任當作單一變項，但在醫療決策中，信任常同時包含認知信任與情感信任，還牽涉平台合法性、可問責性與風險承受。若只測評論可信度，會忽略使用者是否擔心自己暴露隱私、或平台是否可能將資料外流。若只測醫師選擇意圖，也無法理解為何某些匿名機制雖然讓人覺得安全，卻不一定讓人更願意採納。簡言之，現有方法無法同時處理「誰說的是真的」、「說的人會不會被追查」與「我自己會不會暴露」這三個問題，因此不足以回應本研究欲解決的匿名信任困境。

研究動機

本研究的動機來自一個看似矛盾、但在真實世界中極常見的情況：越需要隱私的評論環境，往往越缺乏可驗證性；越追求可信度，往往越要求暴露更多身份資訊。醫療評論尤其如此，因為評論者不只是消費者，而是可能面對疾病污名、醫療紀錄敏感性、就診經歷被推測、甚至醫病衝突後的報復風險。這表示單純引入實名制不一定是好解法，因為它可能直接降低發聲意願，導致評論樣本偏差，最後反而讓平台失去代表性。

因此，本研究的核心動機是：與其強迫評論者在「完全匿名」與「完全實名」之間二選一，不如設計「可證明但不可辨識」的驗證架構。這類架構有機會同時滿足三個目標：第一，讓使用者知道評論來自真實患者，而不是機器人或競爭者；第二，讓評論者不需要暴露可直接識別的身分；第三，讓平台在必要情況下具備有限度的稽核與問責能力。這個方向之所以可能比既有基線更有效，是因為它不把信任建立在單一身份表徵上，而是將信任轉移到「流程可信」與「證明可信」：也就是相信這條評論背後的驗證程序，而非單純相信評論者長什麼樣、叫什麼名字。

本研究的靈感來自數位治理、隱私保護技術與醫療資訊倫理的交會。若能證明某些驗證架構能夠提高平台正當性與評論採納率，同時不顯著增加隱私焦慮，那麼它不只是一個介面設計問題，而是可以推進醫療平台治理與病患資訊賦權的制度創新。更重要的是，這種設計可能適用於台灣與國際情境，特別是在數位醫療、遠距照護、跨院轉診與病患社群平台快速成長的背景下，具有高度現實意義與學術外溢效果。

提出方法

本研究提出一個名為「分層式隱私驗證評論架構」(Layered Privacy Verification for Medical Reviews, LPV-MR) 的社會技術方案，結合設計科學研究與情境實驗。核心概念是：平台不直接揭露評論者身分，而是發出不同強度的「真實患者證明」，讓使用者看到的是一組可解讀的可信訊號，而不是個資本本身。這套架構分成四個層次，每個層次都對應到不同的信任與風險平衡。

第一層是「完全匿名層」：任何人都可發文，僅有一般暱稱與文字內容，作為最低基線。第二層是「驗證病患層」：評論者需透過醫療院所、健保卡一次性驗證、或平台合作之掛號／就診憑證，證明自己曾在某期間接受過該院或該科別服務，但平台只保存不可逆的證明標記，不保存可識別個資。第三層是「第三方保密仲介層」：由獨立受託單位或平台信任模組執行驗證與保管，平台只能看到『通過驗證』與『風險等級』，在爭議事件中可由受控程序啟動有限度稽核。第四層是「可驗證不可識別層」：評論會附帶一個基於區塊鏈或可驗證憑證的標籤，標示該評論確實由某種合格病患身份產生，但不揭露是哪一位病患，且可透過零知識證明或盲簽章確保平台無法將該評論反查回人。

這個方法最大的創新不是區塊鏈本身，而是把『驗證』拆成多個可比較的社會訊號：真實性訊號、責任訊號、隱私保護訊號與平台治理訊號。研究將進一步設計一個原型介面，讓同一則醫師評論在不同驗證架構下呈現不同的標籤與說明。例如，完全匿名只顯示暱稱；驗證病患層顯示『已驗證就診者』；第三方保密仲介層顯示『由獨立機構驗證，平台不可回溯個資』；區塊鏈層顯示『零知識證明已確認病患資格』。使用者不需要理解底層密碼學，也能透過易讀標籤形成對評論可信度與隱私風險的直覺判斷。

在理論上，本研究將建立一個「隱私—可證明性—信任」的中介模型。預期驗證架構會先影響使用者對評論者的感知誠實性、專業相關性與可問責性，進而影響認知信任與情感信任；同時，驗證架構也會影響感知隱私風險與平台合法性。最終，平台合法性與低隱私風險將提升醫師選擇意圖，而過高的透明度若被視為可能暴露病患行蹤，則可能抑制採納。也就是說，本研究不預設「越驗證越好」，而是要找出最佳平衡點：哪一種驗證強度能最大化信任、最小化風險，並維持評論參與意願。

研究設計上，將採兩階段混合方法。第一階段是情境實驗，操弄四種驗證架構與兩種評論效價（正評／負評），並測量使用者的認知信任、情感信任、感知安全、感知隱私風險、平台合法性、評論者可信度與醫師選擇意圖。這能回答哪一種架構最能讓人願意採納評論。第二階段是設計科學原型測試，邀請受試者實際互動一個模擬醫師評價網站，在不同標籤與驗證說明下進行搜尋、瀏覽與決策，藉由行為資料（停留時間、點擊率、選擇變化、回看評論次數）補強自陳量表的不足。若資源允許，可再加入一個質化訪談層，探討使用者如何理解『匿名但可驗證』這種看似矛盾的設計，以及他們對病患保密與平台監督的道德直覺。

最終，本研究希望提出一個可被醫療平台實作的治理框架：不是把所有評論者都變成可識別身份，而是依評論風險、平台功能與社會情境，動態配置不同層級的驗證與可追溯性。如此才能真正回應匿名信任困境，也能為醫療資訊平台提供一套兼顧隱私保護、反作弊與決策支援的設計準則。

實驗計畫

第一步：建立研究材料與原型。先蒐集真實或半真實的醫師評論語料，選擇數個高熟悉度科別（如家醫科、耳鼻喉科、皮膚科）與中性醫療情境，避免受試者因專業差異造成過高認知負擔。接著設計四種評論呈現版本：完全匿名、已驗證就診者、第三方保密仲介驗證、區塊鏈／零知識證明標籤。每個版本都使用相同的評論內容、相同的星等與相同的醫師資訊，確保操弄只來自驗證架構而非內容本身。若採原型系統，需做出可互動的模擬網站，包含搜尋醫師、查看評論、理解標籤說明與做出選擇的流程。

第二步：前測與操弄檢驗。先招募約 30 至 50 位具線上評論使用經驗的受試者，確認四種驗證標籤是否能被理解，且是否真的形成「匿名性高低」、「可信度」、「隱私風險」三種不同知覺。透過操弄檢驗題確認受試者能辨識：哪一種架構最像是可追責、哪一種最保護隱私、哪一種最能代表真實患者。若操弄不明顯，需重新調整標籤文字與圖示，避免正式實驗時失效。

第三步：正式實驗設計。採用 4（驗證架構）×2（評論效價）之受試者間設計，或若希望提高統計效率，可使用平衡的混合設計。樣本建議至少 240 人以上，以確保各條件組有足夠檢定力。受試者來源可分為台灣一般民眾與近期有實際就醫經驗者兩群，後續可比較族群差異。基本控制變項包含：年齡、性別、數位健康素養、個人隱私敏感度、過去醫療評論使用頻率、對醫療體系信任程度。

第四步：測量指標。核心依變項包括：評論者認知信任、情感信任、評論可信度、感知安全、感知隱私風險、平台合法性、評論採納意圖、醫師選擇意圖與資訊分享意願。建議使用經過文獻驗證的量表並在台灣樣本上做信效度檢驗。另可加入行為指標，例如是否點擊『查看更多評論』、是否願意看驗證說明、是否在比較兩位醫師後改變選擇。若加入眼動或點擊流紀錄，可更精細分析不同驗證訊號如何影響注意力分配。

第五步：比較基線方法。至少應比較以下基線：完全匿名、簡單已驗證標籤、人工審核標籤、以及本研究提出的分層式隱私驗證架構。若能加入「實名公開」作為極端對照更佳，但需注意倫理風險。評估重點不是只有平均分數高低，而是檢驗是否存在最佳平衡點：例如某些機制可能最能提升信任，但也最增加隱私風險；而本研究的機制若能在較低隱私風險下達到相近或更高信任，即可視為成功。

第六步：統計分析。可使用 ANOVA / MANOVA 檢驗主效應與交互作用，再以結構方程模型測試『驗證架構→認知／情感信任→醫師選擇意圖』以及『驗證架構→感知隱私風險→平台合法性→選擇意圖』的中介路徑。若加入多群組分析，可比較年齡、隱私敏感度高低、或是否曾有醫療爭議經驗者的差異。若有行為資料，則可用層級迴歸或廣義線性混合模型分析。

第七步：成功判準。若結果顯示，相較完全匿名與一般已驗證標籤，本研究提出的架構能顯著提高評論可信度、認知信任與平台合法性，同時不顯著提高感知隱私風險，並進一步提升醫師選擇意圖與評論採納意願，即可證明「隱私保護驗證」可望緩解匿名與信任的衝突。若發現某些架構在負評情境下效果特別強，亦可形成非常有意思的理論貢獻：也就是說，越敏感、越可能被懷疑的評論，越需要可驗證但不可識別的證明。

第八步：延伸驗證與外部效度。可將同一框架移植到台灣不同醫療平台、不同科別、甚至跨國樣本做比較，測試文化差異與制度差異是否改變偏好。也可加入醫師端或平台管理者訪談，檢驗此機制在真實治理上是否可行。若研究資源充足，建議再做一個小型田野 A/B 測試，觀察在真實流量環境下，驗證標籤是否影響評論閱讀率、停留時間、以及導向掛號或諮詢的行為。成功的結果不只是統計顯著，而

是能證明平台可以在不犧牲病患隱私的前提下，顯著改善醫療評論的可信治理與決策支持。

可信新穎度 — 最接近的真實論文

- How reviewers' profiles affect user's judgment of physicians (61.1% · airiti.AL, 2023) — 增量: 這篇文章主要在匿名醫師評價網站中，操弄評論者的「身份線索」與「經驗線索」，探討這些一般社會線索如何影響使用者對評論、醫師與選擇決策的判斷。你的研究則不是再增加一種身份/經驗線索，而是把核心問題轉為「隱私保護下的真實性驗證」：比較不同驗證架構（如健保卡一次性驗證、第三方保密仲介、零知識證明/區塊鏈標籤）如何同時影響信任、平台正當性感知與隱私風險知覺，方法上也從單純的線上實驗擴展到原型介面與社會技術設計。
- Enhancing the Credibility and Transparency of Academic Peer Review Using Blockchain and Reviewer Quality Control Mechanisms (55.0% · airiti.AL, 2025) — 區隔明確: 這篇論文處理的是學術同行審查系統，重點在於利用區塊鏈與審查者品質控管機制來提升審查透明度、可追責性與審查者評分管理，研究對象是審查流程而不是醫療評論平台。你的研究雖然同樣涉及區塊鏈/可驗證憑證與不可識別性，但要解決的是病患匿名評論中的信任與隱私張力，且測量的是使用者對醫師評論、平台正當性與就醫選擇意圖的反應，而非學術審查品質或 meta-review 流程。
- An Efficient Anonymous Reputation System for Crowdsensing (53.2% · airiti.AL, 2022) — 區隔明確: 這篇文章討論的是 crowdsensing 中如何在伺服器收集敏感位置資料時維持使用者匿名，焦點放在匿名回饋與聲譽系統的技術設計。你的研究則不是一般匿名聲譽機制，而是醫療情境中的評論真實性驗證與信任建構，重點包含醫病關係風險、病歷外洩疑慮、醫師選擇意圖，以及不同驗證層級對平台正當性的影響，因此研究問題與應用脈絡都明顯不同。

參考文獻

1. The Impact of Online Review Related Credibility on Behavioral Intentions on Online Platform
2. How reviewers' profiles affect user's judgment of physicians
3. The Effects of Consumer-Generated Media on Vietnamese Travelers' Decision Making-Mediation Analysis of Perceived Credibility and Trust
4. Trust Prediction in Opinion Sharing Communities: A Learning-Based Classification Approach
5. The Factor Analysis of Trust Process and Reviews' Content to Customer as A Purchasing Reference: Case of Amazon.com
6. How Reviewer Profiles and Review Volume in Product Ratings Affect Viewers' Purchasing Intention and Trust
7. ANONYMOUS EVALUATION AND COMMENT SYSTEM FOR QUALITY OF MEDICAL SERVICE BASED ON BLOCKCHAIN
8. The Relationship among Trust, Satisfaction and Loyalty in Professional Medical Services: The Case of Taiwan
9. A Study for Construct of Extrinsic Cue on Product Evaluation and Effect Measures Model
10. Exploring image in language concreteness reviews and two-sided reviews on online review helpfulness
11. An Investigation of Online Review Sidedness Effect

12. The Impact of Language Arousal and Consumer Values on the Effectiveness of Online Reviews
13. Estimating Reviewer Credibility Using Review Contents and Review Histories
14. The analysis of differences between online book reviews and those in newspapers
15. Crowd sourcing and e-Commerce: Chinese Online Reviews
16. Exploring the Effect of Fake News Characteristic Markings on the Perceived Credibility of Readers with Different Cognitive Style in Fake News
17. The Moderation Effects of Happy and Anger on the Process of Evaluating Persuasive Arguments.
18. 新媒體時代的健康傳播：以「健康力智慧健康服務平台」為例
19. Are negative reviews more credible and useful? The moderating effects of negative emotions and product types
20. A Study on the Persuasive Effect of Online Commenters and Arguments
21. THE CAUSES AND EFFECTS OF USERS ONLINE ANONYMITY CONCERN
22. Whose online reviews to trust? Understanding reviewer trustworthiness and its impact on business
23. Impact of Anonymity on Consumers' Online Reviews
24. Toward a more robust theory and measure of social presence: Review and suggested criteria
25. Social Presence on LinkedIn: Perceived Credibility and Interpersonal Attractiveness Based on User Profile Picture
26. Online first impressions: Person perception in social media profiles
27. Profile Photos' Impact in Online Reviews: The Effect of Cultural Differences
28. Risk assessment in e-commerce: How sellers' photos, reputation scores, and the stake of a transaction influence buyers' purchase behavior and information processing
29. Examining the relationship between reviews and sales: the role of reviewer identity disclosure in electronic markers
30. How fakes make it through: the role of review features versus consumer characteristics
31. The effects of review valence in organic versus sponsored blog sites on perceived credibility, brand attitude, and behavioural intentions
32. An examination of negative e-WOM adoption: Brand commitment as a moderator
33. Eight Questions About Physician-Rating Websites: A Systematic Review
34. An Analysis of Online Evaluations on a Physician Rating Website: Evidence From a German Public Reporting Instrument

35. A Changing Landscape of Physician Quality Reporting: Analysis of Patients' Online Ratings of Their Physicians Over a 5-Year Period
36. What Do Patients of Different Medical Illness Say About Their Doctors Online? An Analysis of Online Physician Reviews

從評論信任到醫病忠誠：線上醫師評論如何驅動回診、依從與醫院轉移？

後設資料

想法編號: seed-theory-2=>3=>2=>1

新穎度: 26.1%

最大相似度: 73.9% (近似於: “How reviewers’ profiles affect user’s judgment of physicians”)

群集: 6

競賽得分: 0 勝

方法論契合度: 2/5

問題陳述

線上醫師評論已不只是幫助病患「選哪位醫師」的資訊線索，而是可能進一步塑造病患後續的就醫行為、醫病關係品質，甚至影響病患是否持續留在同一家醫院。現有研究多停留在評論可信度、評論者身份線索、評論效價如何影響選擇意向，較少處理一個更重要但更複雜的問題：當病患真的進入醫療情境後，這些由陌生人所寫、匿名程度不一的評論，是否會延伸成對醫師的初始信任，進而影響就診滿意、回診意圖、服藥與照護依從、醫師忠誠與醫院忠誠？更進一步地，在台灣這種醫院與醫師高度綁定、病患選擇醫師常同時牽動醫院選擇的封閉式醫療體系中，個人層次信任（對醫師）與系統層次信任（對醫院）是否彼此轉移、相互增強，仍缺乏嚴謹驗證。

這個問題之所以重要，在於線上評論可能不只是「資訊」，而是醫療市場中的一種關係前置機制：它先改變病患對醫療服務的心理預期，再影響實際互動與後續忠誠。若高信任評論會提高回診率與依從性，那麼評論平台的設計、醫院的品牌管理、醫師的數位聲譽治理，都會被重新定義。若不同病況嚴重度、慢性病/急性病與醫療風險知覺下，評論效果大幅不同，則醫療資訊平台與衛教策略也需要分眾。此研究因此不只是探討「哪類評論最有說服力」，而是要回答「評論如何從認知線索變成醫療關係與制度忠誠的起點」，具有理論與實務上的雙重價值。

現有方法

既有方法大致可分為三類。第一類是線上評論效應研究，常以評論者身份線索、匿名性、評價星等、評論長度、情緒傾向與評論幫助性作為自變項，主要解釋醫師選擇意向、點擊意圖或對評論者的信任。這類研究的限制在於，結果多停留在「選擇前」階段，較少追蹤到真實醫療互動之後的行為結果，也少有把評論可信度與後續病患忠誠、回診、依從連結起來。

第二類是醫病關係與服務管理研究，常以信任、滿意、忠誠作為中介鏈，驗證病患對醫師或醫院的信任如何影響持續使用與推薦意圖。這類研究優點是能處理長期關係，但常忽略信任的來源，通常把信任視為既成狀態，而不是由線上資訊先行塑造。它們也較少區分個人層次與系統層次信任，導致難以辨識忠誠究竟是對醫師、對機構，還是兩者之間的轉移。

第三類是單次橫斷式問卷或實驗研究，雖可操縱正負評、身份線索或經驗線索，但通常樣本較小、情境較抽象，無法反映真實就醫的時間延遲與行為落差。少數平台資料研究雖可看到評論與流量、預約、回訪的關聯，卻常缺乏病患感知層的心理機制，難以說明為何同樣的評論對不同病患產生不同效果。簡言之，既有方法要嘛有機制、無行為，要嘛有行為、無機制，尚不足以解釋「評論信任如何一路轉化成醫病忠誠與醫院黏著度」。

研究動機

本研究的核心動機，是把醫師評論從「選擇工具」重新概念化為「關係啟動器」。這個轉向很重要，因為醫療決策不同於一般消費決策：病患面對的是高不確定性、高風險、資訊不對稱與情感脆弱的情境，因此評論的影響不會只停留在當下偏好，而可能延伸到後續遵從、持續就醫與機構忠誠。現有方法之所以不足，是因為它們多半把評論可信度視為靜態屬性，沒有看到它在醫療歷程中會動態生成：評論先影響初始信任，初始信任再影響第一次就診感受，而第一次就診經驗會回頭修正病患對評論的再評估，形成一個可累積、可放大的循環。

我們的靈感來自三個方向的結合：第一，社會訊息處理理論可以說明評論者身份與經驗線索如何塑造信任；第二，服務關係行銷中的滿意—忠誠模型可說明信任如何轉化為持續關係；第三，醫療脈絡中個人與系統信任的雙層結構，可用來解釋忠誠是否會從醫師轉移到醫院。若能把這三者串成「評論線索 → 初始信任 → 就診滿意 → 回診/依從 → 醫師忠誠 → 醫院忠誠」的多階段模型，就能超越傳統的單意向研究。

更大膽但可行的創新，是把「忠誠轉移」視為醫療平台與醫院管理的新現象：病患可能不是因為喜歡某位醫師而留在醫院，而是因為對這位醫師的信任被制度化地轉移到整個醫院品牌。反過來，也可能因為醫院品牌很強，讓匿名評論中醫師的聲譽被放大。這種雙向轉移若能被證實，將能為台灣與國際醫療資訊研究提供一個比「評論是否有用」更高層次的理論貢獻。

提出方法

本研究提出一個「雙層信任—忠誠轉移動態模型」(Dual-level Trust-Loyalty Transfer Model, DTTL)，將線上醫師評論視為醫療關係建立的前置刺激，並以多階段、可驗證的方式追蹤其後續影響。整體設計分成四個核心模組。

第一個模組是「評論線索解碼層」。我們不只操縱評論的正負評，還加入三種更接近真實平台的線索：評論者身份線索（如頭像風格、暱稱的可辨識程度、是否帶有生活角色訊號）、經驗線索（是否有多次同類主題評論、是否呈現具體就醫經歷、是否提及醫療流程細節）、以及評論語氣中的風險訊號（例如是否提及副作用、診斷不確定性、等待時間、溝通困難）。這些線索不直接視為「好或壞」，而是作為病患在高不確定醫療情境中辨識評論可信度的訊息基礎。此模組的目標是建構一個比傳統「匿名 vs 非匿名」更細緻的評論可信度生成機制。

第二個模組是「初始信任生成層」。我們將信任拆成兩個層次：對醫師的個人信任與對醫院的系統信任。評論首先影響的是病患對醫師的初始認知信任與情感信任，例如「這位醫師看起來專業可靠」、「這位醫師似乎理解病人」。接著，當病患把醫師視為醫院的代表時，這種信任會部分轉移到醫院層次，形成對醫院流程、品質與整體治理的推定信任。我們將特別測試一個關鍵路徑：評論可信度是否先提升對醫師的信任，再透過診療體驗轉移到對醫院的信任，而非直接從評論跳到醫院品牌。

第三個模組是「歷程追蹤層」。這是本研究最重要的創新之一。我們不只收集一次性問卷，而是設計三波追蹤：第一波在觀看評論後立即測量評論可信度、對醫師的初始信任、醫療風險知覺與就醫預期；第二波在實際或情境化就診後測量就診滿意、心理安全感、理解感與依從意圖；第三波在一段時間後追蹤回診意圖、實際回診行為、對醫師忠誠、對醫院忠誠與轉院/轉診意圖。若能串接平台評論資料與門診回訪資料，則可進一步把自陳意圖升級為真實行為資料，形成準實驗式的行為驗證。

第四個模組是「情境調節層」。我們預期評論效果不會對所有人一樣，因此引入三個調節因子：病況嚴重度、慢性病/急性病類型、以及醫療風險知覺。對慢性病患者而言，長期關係與可持續性重要，評論較可能影響回診與醫院黏著；對急性病患者而言，評論也許更像一次性選擇工具。對高風險知覺者而言，評論中的經驗線索與身份線索可能更關鍵，因為他們更依賴外部社會訊號來降低不確定感。這些條件將納入多層次模型，檢驗是否存在「高信任評論只在高風險、高慢病負擔下，才會真正轉化為忠誠」的邊界條件。

方法上，我們建議採用「實驗+追蹤+平台資料」的混合研究設計。第一階段是情境實驗，使用醫師評論頁面的仿真介面，操縱評論線索並測量即時認知與情感反應。第二階段是追蹤式問卷，模擬或記錄受試者真實的後續就醫歷程，觀察滿意與忠誠是否形成。第三階段則是資料串接，從合作醫療平台或醫

院端取得評論曝光、點擊、預約、回診與轉院指標，透過匿名化方式進行行為分析。若資料取得受限，也可先以高擬真情境實驗結合滾動式追蹤完成主要檢驗。

分析策略上，建議使用結構方程模型與跨時點中介分析，搭配多群組比較與潛在成長模型，驗證不同病況族群的路徑差異。若可取得平台行為資料，則可進一步以事件史分析或生存分析檢驗「首次信任是否延長留在同一醫院的時間」。為增加創新性，也可加入生成式文本分析：以評論文本的具體性、風險披露程度、第一人稱敘述與情緒調節語句作為客觀特徵，與實驗操縱相互驗證，建立評論可信度的內容—感知雙層模型。

總結而言，本研究的最大特色不只是驗證評論影響選擇，而是把評論放入醫療關係的整個生命週期中，將其視為一個可驅動信任生成、滿意累積、依從實踐與忠誠轉移的社會資訊機制。這種設計在理論上能連接資訊行為、醫療服務行銷與數位健康研究，在實務上則可直接回應台灣醫療平台、醫院與醫師如何管理線上聲譽與病患黏著。

實驗計畫

第一步是建立研究資料與情境。資料來源建議分成三類：一是線上醫師評論平台資料，例如台灣常見醫師評價網站上的公開評論，萃取評論者匿名程度、頭像線索、ID 可辨識度、評論長度、效價、風險語句與經驗敘述；二是受試者資料，招募近期有搜尋醫師經驗的民眾，並依慢性病/急性病、病況嚴重度與醫療風險知覺進行分層；三是追蹤資料，若能與合作醫院或平台串接，則蒐集預約、就診、回診與轉院紀錄，否則以三波問卷追蹤替代。

第二步是進行情境實驗。可設計 2（評論效價：正/負）× 2（身份線索：高/低）× 2（經驗線索：有/無）之組內或混合設計，先讓受試者瀏覽仿真的醫師評論頁，再測量評論可信度、對醫師信任、對醫院信任、就診意願。可加入操作檢核題，例如「你覺得這位評論者是否具體描述自己的就醫經驗？」以確認操縱有效。

第三步是三波追蹤。Wave 1 在曝光評論後立即測量：評論可信度、認知信任、情感信任、風險知覺與初始選擇意向。Wave 2 在一週到一個月後測量：實際或情境化就診滿意、理解感、安心感、依從意圖。Wave 3 在一到三個月後測量：回診率、自述依從、醫師忠誠、醫院忠誠、轉院意圖。若有真實行為資料，則以平台/醫院紀錄替代或補充自陳。

第四步是基線與比較模型。基線可包含：只用星等與評論數量的簡化模型、只用正負評論分數的文本模型、只用評論者匿名性與長度的線索模型，以及傳統的單階段「評論可信度→選擇意向」模型。我們的模型預期優於基線，原因在於它同時納入多層信任、跨時點結果與情境調節，能解釋更完整的因果鏈。

第五步是評估指標。若採結構方程模型，重點看路徑係數、間接效果、模型擬合指標與多群組差異；若採行為資料，則使用回診率、轉院率、留存時間、依從完成率作為主要結果變項。若進行分類預測，也可比較 AUC、F1、校準度與決策曲線分析，檢驗高信任評論是否能提升預測真實忠誠的能力。成功的判準應包含：1) 評論可信度能顯著預測對醫師的初始信任；2) 初始信任能進一步預測滿意、回診與依從；3) 醫師忠誠可部分轉移到醫院忠誠；4) 此轉移在慢性病、高風險知覺族群更強；5) 高信任評論不只提高選擇意向，也能提升實際回診或留存。

第六步是可選的高風險但高回報延伸：將評論文本送入大型語言模型做結構化標註，萃取「具體經驗」、「風險揭露」、「同理語句」、「流程細節」等特徵，再與人工編碼對照，建立可移植到其他醫療平台的評論可信度指標。這一步可讓研究從單一平台情境升級為可跨平台、跨地區複用的醫療評論理論框架。若結果顯示雙層信任轉移成立，且在慢病/高風險族群中最顯著，便能證明線上醫師評論的影響並非僅止於選擇，而是會深度進入病患的醫療持續性與醫院黏著，這將是一個在圖書資訊學、醫療資訊行為與服務研究都具有高影響力的發現。

可信新穎度 — 最接近的真實論文

- How reviewers' profiles affect user's judgment of physicians (73.9% · airiti.AL, 2023) — 增量: 這篇論文主要在 2×2×2 實驗中檢驗「評論者的身份與經驗線索」如何影響使用者對醫師的判

斷、信任與醫師選擇，重點停留在選擇決策與當下認知反應。你的提案則進一步追蹤評論如何延伸到就診後的回診、服藥/照護依從、醫師忠誠與醫院忠誠，並明確檢驗醫師層次信任如何轉移到醫院層次信任；這是它沒有處理的歷程與結果層次。

- The Impact of Online Review Related Credibility on Behavioral Intentions on Online Platform (63.2% · airtiti.AL, 2017) — 區隔明確：這篇研究雖然同樣談「評論可信度、評論者可信度、平台/商家信任與行為意圖」，但它的情境是一般電商平台上的網路評論，主要結果是對商家與平台的信任及購買行為意圖。你的提案聚焦醫療情境，且把結果擴展到回診、依從、醫師忠誠與醫院忠誠，還加入醫病關係與系統層次信任轉移，這些都不是該文的核心問題。
- What Makes Helpful Online Reviews to the Formation of Trustworthiness? An Experimental Study on the Effectiveness of Review Arrangement across Products (58.4% · airtiti.AL, 2011) — 區隔明確：這篇論文的核心是在不同產品類別中，透過實驗比較評論排序/安排方式如何影響評論助益性與信任形成，重點是「如何讓評論更有幫助、如何形成可信度」。你的提案不是在研究評論排列或助益性知覺，而是把評論線索當作醫療關係的前置刺激，進一步追蹤到就診後滿意、依從、回診與忠誠，因此研究問題與結果變項層次明顯不同。

參考文獻

1. How reviewers' profiles affect user's judgment of physicians
2. The Relationship among Trust, Satisfaction and Loyalty in Professional Medical Services: The Case of Taiwan
3. Exploring the mediating roles of heart failure patients' obedience and security-seeking in the relationships between patients' trust in cardiologists and their physical and psychological outcomes
4. The Effect of Information Quality on Product Demand:Evidence from Yahoo! Auctions Taiwan
5. The Effects of Messenger Factors and Sense of Presence on Value of Location-based Service Review: A Perspective of Co-presence Theory
6. The Influence of Message Framing and Web Context on Blog eWOM Effectiveness - The Moderating Role of Involvement
7. The Impact of Online Review Related Credibility on Behavioral Intentions on Online Platform
8. A Study on the Persuasive Effect of Online Commenters and Arguments
9. The Influences of Product Review Credibility and Product Rating Credibility on Browsers' Product Attitudes: An Online Platform of Cosmetics
10. The Determinants and Outcome of Trust Between Patient and Doctor - In case of Hemodialysis Centers
11. The Impact of Online Review and Price on Hotel Booking Intention at Online Travel Agency: Trust as a Mediating Variable
12. Aspect-Based Review Helpfulness Prediction
13. Evaluating the Helpfulness of Online Hotel Reviews

14. Helpfulness Analysis for Movie Reviews
15. Recommender Systems: Perspective and Main Research Themes
16. A Study of the Use Satisfaction on the Service Quality of the Library Website from the Physical Information Needs' Concepts – An Example of the China Medical Hospital Library
17. A Bayesian Statistical Model Based Outpatient Department Decision Support
18. The Study of Impact Factors and Prediction Models on Patients' Health Care Behavior
19. Investigating the Structural and Textual Characteristics of Internet Physicians Review
20. The Effect of Online Word-of-Mouth on Consumer's Purchase Intention: A Laboratory Experiments Conducted on Online Forum
21. 線上評論與購買意願之餐旅文獻統合分析
22. Trust Prediction in Opinion Sharing Communities: A Learning-Based Classification Approach
23. Investigating Patient Selection in the Pay-for-Performance Program for Diabetes
24. An Observational Study of Google Reviews and Ratings of Medical Institutions
25. The Factor Analysis of Trust Process and Reviews' Content to Customer as A Purchasing Reference: Case of Amazon.com
26. How Reviewer Profiles and Review Volume in Product Ratings Affect Viewers' Purchasing Intention and Trust
27. Investigation on Health Care Choice and Utilization of Preventive Health Care Service of Young People: Healthcare Workers vs. Non-healthcare Workers
28. The Effect of Social Cues and Informational Cues on Consumers' Trust and Trust Performance
29. Estimating Reviewer Credibility Using Review Contents and Review Histories
30. The Study of Relationship Between Breast Cancer Patients' Trust and Evaluation toward Physician
31. Exploring Factors of the Opinions on Hospital Information Disclosure and Its Behavioral Intention Influence by Orthopedic Surgeons: An Example in Report Card of Total Knee Replacement
32. Whose online reviews to trust? Understanding reviewer trustworthiness and its impact on business
33. Impact of Anonymity on Consumers' Online Reviews
34. Toward a more robust theory and measure of social presence: Review and suggested criteria
35. Social Presence on LinkedIn: Perceived Credibility and Interpersonal Attractiveness Based on User Profile Picture
36. Online first impressions: Person perception in social media profiles

37. Profile Photos' Impact in Online Reviews: The Effect of Cultural Differences
38. Risk assessment in e-commerce: How sellers' photos, reputation scores, and the stake of a transaction influence buyers' purchase behavior and information processing
39. Examining the relationship between reviews and sales: the role of reviewer identity disclosure in electronic markers
40. How fakes make it through: the role of review features versus consumer characteristics
41. The effects of review valence in organic versus sponsored blog sites on perceived credibility, brand attitude, and behavioural intentions
42. An examination of negative e-WOM adoption: Brand commitment as a moderator
43. Eight Questions About Physician-Rating Websites: A Systematic Review
44. An Analysis of Online Evaluations on a Physician Rating Website: Evidence From a German Public Reporting Instrument
45. A Changing Landscape of Physician Quality Reporting: Analysis of Patients' Online Ratings of Their Physicians Over a 5-Year Period
46. What Do Patients of Different Medical Illness Say About Their Doctors Online? An Analysis of Online Physician Reviews